中 国 针 灸 学 会 标 准

ZJ/T E014—2015

循证针灸临床实践指南
膝骨关节炎

Evidence-based Guidelines of Clinical Practice with Acupuncture and Moxibustion Knee Osteoarthritis

2015-07-10 发布　　2015-07-10 实施

中国中医药出版社

图书在版编目(CIP)数据

循证针灸临床实践指南：膝骨关节炎/中国针灸学会．—北京：中国中医药出版社，2015.7
ISBN 978－7－5132－2528－1

Ⅰ.①膝…　Ⅱ.①中…　Ⅲ.①膝关节－关节炎－针灸疗法　Ⅳ.①R246.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 115668 号

中国针灸学会
循证针灸临床实践指南：膝骨关节炎
ZJ/T E014－2015
*
中 国 中 医 药 出 版 社 出 版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
网址 www.cptcm.com
传真 010 64405750
三河双峰印刷有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230　1/16　印张 3.25　字数 98 千字
2015 年 7 月第 1 版　2015 年 7 月第 1 次印刷
*
书号 ISBN 978－7－5132－2528－1　定价 39.00 元
*
如有质量问题请与本社出版部调换
版权专有　侵权必究
社长热线 010 64405720
读者服务部电话 010 64065415 84042153
书店网址 csln.net/qksd/

目　　次

前言 ……（Ⅰ）
引言 ……（Ⅲ）
摘要 ……（1）
1　治疗原则 ……（1）
2　主要推荐意见 ……（1）
简介 ……（2）
1　本《指南》制定的目标 ……（2）
2　本《指南》制定的目的 ……（2）
3　本《指南》的适用人群 ……（2）
4　本《指南》适用的疾病范围 ……（2）
概述 ……（3）
1　定义 ……（3）
2　发病率及人群分布情况 ……（3）
临床特点 ……（4）
1　病史 ……（4）
2　症状及体征 ……（4）
诊断标准 ……（5）
1　西医诊断标准 ……（5）
2　中医诊断标准及分型 ……（6）
针灸治疗概况 ……（7）
1　现代文献 ……（7）
2　古代文献 ……（7）
3　名医经验 ……（7）
针灸治疗和推荐方案 ……（9）
1　针灸治疗的原则和特点 ……（9）
2　主要结局指标 ……（9）
3　注意事项 ……（9）
4　患者自我护理 ……（10）
5　推荐方案 ……（10）
参考文献 ……（17）
附录 ……（26）
1　本《指南》专家组成员和编写组成员 ……（26）
2　临床问题 ……（27）
3　疗效评价指标的分级 ……（27）
4　检索范围、检索策略和结果 ……（27）
5　文献质量评估结论 ……（28）
6　本《指南》推荐方案的形成过程 ……（38）
7　本《指南》推荐方案征求意见稿 ……（41）
8　专家意见征集过程、结果汇总及处理 ……（41）
9　会议纪要 ……（41）

前　　言

《循证针灸临床实践指南》包括：带状疱疹、贝尔面瘫、抑郁症、中风后假性球麻痹、偏头痛、神经根型颈椎病、慢性便秘、腰痛、原发性痛经、坐骨神经痛、失眠、成人支气管哮喘、肩周炎、膝骨关节炎、慢性萎缩性胃炎、过敏性鼻炎、突发性耳聋、原发性三叉神经痛、糖尿病周围神经病变、单纯性肥胖病等病症的循证针灸临床实践指南。

本部分为《循证针灸临床实践指南》的膝骨关节炎部分。

本部分受国家中医药管理局指导与委托。

本部分由中国针灸学会提出。

本部分由中国针灸学会标准化工作委员会归口。

本部分起草单位：天津中医药大学、中国中医科学院针灸研究所。

本部分主要起草人：郭义、翟伟、黄娟、赵雪、陈泽林、李桂兰、任秋兰。

本部分参与起草人：谭亚芹、田利娟、姜锐、郝华、奥晓静、柳青、金兰、杨毅、王红。

本部分专家组成员：刘保延、赵宏、武晓冬、房緊恭、吴泰相、赵吉平、刘志顺、吴中朝、王麟鹏、刘炜宏、詹思延、史丽萍、孟向文、高旸、潘兴芳、刘爱峰、郭长青、贾春生、高希言、张洪涛、李义凯、回克义、杨永晖、齐伟、杨克虎、陈耀龙、梁繁荣、张维、杨金生、文碧玲、余曙光、杨骏、赵京生、杨华元、储浩然、石现、王富春、余晓阳、常小荣、吕明庄、王玲玲、宣丽华、东贵荣、王华、刘清国、刘智斌、曹炀、高树中、杨永清、朱江、岗卫娟、王昕、董国峰、王芳。

引　言

《循证针灸临床实践指南》是根据针灸临床优势，针对特定临床情况，参照古代文献、名医经验以及现代最佳临床研究证据，结合患者价值观和意愿，系统研制的帮助临床医生和患者做出恰当针灸处理的指导性意见。

《循证针灸临床实践指南》制定的总体思路是：在针灸实践与临床研究的基础上，遵循循证医学的理念与方法，紧紧围绕针灸临床的特色优势，综合专家经验、目前最佳证据以及患者价值观，将国际公认的证据质量评价与推荐方案分级的规范与古代、前人、名老针灸专家临床证据相结合，并将临床研究证据与大范围专家共识相结合，旨在制定出能保障针灸临床疗效和安全性，并具有科学性与实用性的有效指导针灸临床实践的指导性意见。

在《循证针灸临床实践指南》的制定过程中，各专家组共同参与，还完成了国家标准《针灸临床实践指南制定与评估规范》（以下简称《规范》）的送审稿。《规范》参照了国际上临床实践指南制定的要求和经验，根据中国国情以及针灸的发展状况，对《循证针灸临床实践指南》制定的组织、人员、过程、采用证据质量评价、推荐方案等级划分、专家共识形成方式、制定与更新的内容和时间等进行了规范。这些规范性要求在《循证针灸临床实践指南》制定中都得到了充分考量与完善。《规范》与《循证针灸临床实践指南》相辅相成，《规范》是《循证针灸临床实践指南》制定的指导，《循证针灸临床实践指南》又是《规范》适用性的验证实例。

《循证针灸临床实践指南》推荐等级主要采用世界卫生组织（WHO）等推荐的 GRADE（Grading of Recommendations Assessment，Development and Evaluation）系统，即推荐分级的评价、制定与评估的系统，其中推荐等级分为强推荐与弱推荐两级。强推荐的方案是估计变化可能性较小、个性化程度低的方案，而弱推荐方案则是估计变化可能性较大、个性化程度高、患者价值观差异大的方案。对于古代文献和名医经验的证据质量评价，目前课题组还在进一步研制中，《循证针灸临床实践指南》仅将古代文献和名医经验作为证据之一附列在现代证据之后，供《循证针灸临床实践指南》使用者参考。

2008 年，在 WHO 西太区的项目资助下，由中国中医科学院牵头、中国针灸学会标准化工作委员会组织完成了针灸治疗带状疱疹、贝尔面瘫、抑郁症、中风后假性球麻痹和偏头痛 5 种病症的指南研制工作。在这 5 种病症的指南研制过程中，课题组初步提出了《循证针灸临床实践指南》的研究方法和建议，建立了《循证针灸临床实践指南》的体例、研究模式与技术路线。2010 年 12 月，《临床病症中医临床实践指南·针灸分册》由中国中医药出版社正式出版发行。

2009 年至 2013 年，在国家中医药管理局立项支持下，中国针灸学会标准化工作委员会又先后分 3 批启动了 15 种病症的指南研制工作。为了保证《循证针灸临床实践指南》高质量地完成，在总课题组的组织下，由四川大学华西医院吴泰相教授在京举办 2 次 GRADE 方法学培训会议，全国 11 家临床及科研单位的 100 多位学员接受了培训。随后，总课题组又组织了 15 个疾病临床指南制定课题组和 1 个方法学课题组中的 17 位研究人员，赴华西医院循证医学中心接受了为期 3 个月的 Meta 分析和 GRADE 方法学专题培训，受训研究人员系统学习并掌握了 GRADE 系统证据质量评价和推荐意见形成的方法。

本次出版的《循证针灸临床实践指南》共有 20 个部分，包括对 2010 年版 5 部分指南的修订再版

和 2013 年完成的 15 部分指南的首次出版。《循证针灸临床实践指南》的适用对象为从事针灸临床与科研的专业人员。

《循证针灸临床实践指南》的证据质量分级和推荐等级如下：

◇证据质量分级

证据质量高：A

证据质量中：B

证据质量低：C

证据质量极低：D

◇推荐强度等级

支持使用某项干预措施的强推荐：1

支持使用某项干预措施的弱推荐：2

《循证针灸临床实践指南》的编写，凝聚着全国针灸标准化科研人员和管理人员的辛勤汗水，是参与研制各方集体智慧的结晶，是辨证论治的个体化诊疗模式与循证医学有机结合的创造性探索。《循证针灸临床实践指南》在研制过程中，得到了兰州大学循证医学中心杨克虎教授、陈耀龙博士以及北京大学循证医学中心詹思延教授在方法学上的大力支持和帮助，在此深表感谢。同时，还要感谢国家中医药管理局政策法规与监督司领导的热心指导与大力支持，感谢各位专家的通力合作。此外，在《循证针灸临床实践指南》的出版过程中，中国中医药出版社表现出了很高的专业水平，在此一并致谢。

摘　　要

1　治疗原则

针灸治疗膝骨关节炎应在明确病因的基础上对症治疗。总的原则：舒筋利节，活络止痛；选穴以阿是穴及局部经穴为主，可结合辨证及循经远端取穴。

建议将针刺作为治疗膝骨关节炎的基础疗法，应用于疾病发生、发展的各期，可结合温针疗法、电针、推拿、中药、理疗、功能锻炼等综合施治，也可使用艾灸、穴位注射、刺络拔罐、火针、针刀等疗法。以缓解疼痛、保护关节功能、阻止和延缓疾病的发展、改善生活质量为治疗的主要目标。

2　主要推荐意见

推荐意见	推荐级别
（1）膝骨关节炎膝关节疼痛、晨僵、肿胀、功能受限者，建议采用毫针刺法	强推荐
（2）膝骨关节炎膝关节疼痛较剧、遇寒尤甚、晨僵、肿胀、功能受限，证属阳虚寒凝、湿着关节、筋脉瘀滞者，推荐采用温针疗法	强推荐
（3）膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、畸形、肌肉萎缩、功能受限，推荐采用电针为主治疗	强推荐
（4）膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、功能受限，可采用穴位注射治疗	弱推荐
（5）膝骨关节炎膝关节功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显，证属阳虚寒凝、筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，建议采用火针治疗	强推荐
（6）膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、肿胀、屈膝畸形、功能受限，证属筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，可采用刺络放血拔罐治疗	弱推荐
（7）膝骨关节炎膝关节隐痛、遇寒尤甚、晨僵、功能受限，证属阳虚寒凝、肝肾不足、筋脉瘀滞、湿着关节者，可采用艾灸治疗	弱推荐
（8）膝骨关节炎膝关节肌肉粘连、功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显者，建议采用针刀治疗	强推荐
根据患者主要症状，结合每一针灸疗法的特点，可选择几种针灸治疗措施综合使用	—

简　　介

《循证针灸临床实践指南：膝骨关节炎》（以下简称《指南》）简介如下：

1　本《指南》制定的目标

根据现有的临床证据、古代文献证据及临床专家经验，制定出临床实用性较强的膝骨关节炎循证针灸临床实践指南。

2　本《指南》制定的目的

本《指南》制定的目的是促进国内膝骨关节炎针灸治疗方案的规范化，为临床治疗膝骨关节炎提供可靠证据，确保治疗的安全性和有效性。

3　本《指南》的适用人群

本《指南》的适用人群主要为执业（助理）医师（包括经规范中医药培训的临床类别医师）、护理人员、患者、医学院校从事中医药教育的教师和学生、中医药科研机构相关人员。

本《指南》应用的目标环境包括国内各级医院针灸科门诊部或住院部，有针灸专业医师的基层、社区、医院，有针灸专业的大学或学院，各针灸相关的科研及评价机构。

4　本《指南》适用的疾病范围

本《指南》适用的疾病主要是膝骨关节炎（knee osteoarthritis，KOA；ICD－10：M17），本病是骨科常见病，又称为膝关节增生性关节炎、退行性关节炎、肥大性关节炎、老年性关节炎等。主要针对原发性膝骨关节炎，或者是继发于创伤、代谢性疾病、先天畸形、缺血坏死的膝骨关节炎，以及中医所指的痹证、骨痹等主要累及膝关节的疾病。

概　　述

1　定义

1.1　西医

膝骨关节炎，属于骨性关节炎的一种，是指膝关节关节面软骨发生原发性或继发性退变及结构紊乱，伴随软骨下骨质增生、软骨剥脱，从而使关节逐渐破坏、畸形，最终发生膝关节功能障碍的一种退行性疾病。此为骨科临床常见病，又称为膝关节增生性关节炎、退行性关节炎、肥大性关节炎等。

其主要临床表现为缓慢发生发展的关节疼痛、僵硬、压痛、捻发音、肿大且伴有功能活动受限，严重者导致关节功能障碍甚至残疾，是引起老年人疼痛和伤残的重要原因之一。

1.2　中医

本病属于“痹证”“骨痹”的范畴，为肝、脾、肾亏虚，风、寒、湿邪外袭，客于局部，经络不通所致。《素问·痹论》指出“风、寒、湿三气杂至，合而为痹”，“以冬遇此者为骨痹，以春遇此者为筋痹”，“骨痹不已，复感于邪，内舍于肾”。《素问·长刺节论》云：“病在骨，骨重不可举，骨髓酸痛，寒气至，名曰骨痹。”

2　发病率及人群分布情况

膝骨关节炎的发生常认为是在全身情况下及关节特有的机械环境引起的，产生的因素可分为全身性和机械性两种。膝骨关节炎的发病与性别、年龄、体质量指数、职业等因素有关，其中年龄因素占的比例最高，其次是性别、体质量指数、职业[1]。

X 线检查膝骨关节炎流行病学调查显示，24～45 岁女性的发病率为 1%～4%，45 岁及以下男性的发病率占 1%～6%。老年人是高危人群，65 岁以上人群患病率可达 50% 左右，75 岁以上人群患病率可达 80% 左右。

研究发现，女性的发病率更高，而且发病率随年龄的增大而增加。每 10 万人中一年就有 240 人患有此病。其次，因职业因素发病的人数较多，科教文卫最少。工人发病的体质量指数值较小，且发病年龄较早。此外，体质量指数值和年龄呈正相关性，尤以 50 岁以上人群体质量指数值明显偏大[2]。

临 床 特 点

1　病史

骨关节炎是引起成人局部或广泛关节疼痛的常见原因，起病缓慢，并无明显症状，呈良性的发展过程。原发性骨关节炎随年龄的增长而逐渐加重。继发于创伤、代谢性疾病、先天畸形、缺血坏死的骨关节炎发病较早。膝骨关节炎发生的危险因素主要包括：年龄大于 50 岁，女性，患有骨性关节炎，直系亲属中有骨性关节炎患者，既往有膝或髋的损伤史，肥胖或者工作需要屈膝或者需要搬抬重物的人群等。

疾病发展过程中会有静止期或代偿期。本病的病程缓慢，表现复杂，不能确定疾病是否发作，患者和患者之间病情加重速度不同，在如何确定病情进展方面没有一致的意见。疾病的终末期可出现明显的疼痛症状、僵硬、关节活动受限，导致关节失用[1]。

膝骨关节炎是一种终生性疾病，目前没有证据显示早期发现能改变其进程，然而早期干预则有利于功能的保留。

2　症状及体征

膝骨关节炎的病理形态改变主要为局限性、进行性关节软骨破坏及关节边缘的骨赘形成。现已证明多种原因可造成关节软骨的破坏，其内在原因是由于关节软骨本身的改变，或由于机械性的外伤或炎症等因素造成软骨损伤，进而使软骨成分（隐蔽抗原）暴露，引起自身免疫反应，造成继发性损伤。[2,3]

2.1　症状

膝骨关节炎早期症状：膝关节疼痛，多见于内侧疼痛，上下楼或站起时尤甚，无明显畸形。中期症状：疼痛较重，可合并肿胀，内翻畸形，有屈膝畸形及活动受限。晚期症状：疼痛严重，行走需支具或不能行走，内翻及屈膝畸形明显。[4,5]

2.2　体征

可有摩擦音，髌骨研磨试验阳性，髌周压痛阳性，股四头肌萎缩，关节肿大或者屈曲挛缩甚至僵直，韧带无力、骨性增大、软骨破坏、半脱位及挛缩，还可引起关节的排列不良而造成畸形。此外，患者在晚期还可见肌肉萎缩、关节不稳定等。[4,5]

膝关节 X 线检查可见关节间隙狭窄，髁间棘增生，关节边缘骨赘，关节面下骨板硬化，关节内游离体形成等。对于关节的物理检查可为诊断提供有价值的线索和证据。

诊 断 标 准

1 西医诊断标准

西医诊断标准参照中华医学会骨科学分会《骨关节诊治指南》（2007 年版）。

1.1 临床表现

膝关节的疼痛及压痛、关节僵硬、关节肿大、骨摩擦音（感）、关节无力、活动障碍。

1.2 X 线检查

膝骨关节炎的 X 线特点：早期表现为正常或关节间隙可疑变窄，可能有骨赘；中期表现为有明显的骨赘，关节间隙轻度变窄，软骨下骨质轻度硬化改变，范围较小；晚期表现为大量骨赘形成，可波及软骨面，关节间隙明显变窄，硬化改变极为明显，关节肥大及明显畸形。

1.3 实验室检查

血、尿常规化验均正常；血沉正常，抗“O”及类风湿因子阴性，关节液为非炎性。伴有滑膜炎者可见 C 反应蛋白（CRP）及血沉（ESR）轻度升高。继发性膝骨关节炎的患者可出现原发病的实验室检查异常。

1.4 诊断标准

（1）近 1 个月内反复膝关节疼痛。

（2）X 线（站立或负重位）示关节间隙变窄、软骨下骨硬化和（或）囊性变、关节缘骨赘形成。

（3）关节液（至少 2 次）清亮、黏稠，WBC＜2000 个/mL。

（4）中老年患者（≥40 岁）。

（5）晨僵≤30 分钟。

（6）活动时有骨擦音（感）。

综合临床、实验室及 X 线检查，符合(1)＋(2)条或(1)＋(3)＋(5)＋(6)条或(1)＋(4)＋(5)＋(6)条，可诊断为膝骨关节炎。

1.5 膝骨关节炎的分级

根据 Kellgren 和 Lawrecne 的放射学诊断标准，膝骨关节炎分为五级：

0 级：正常。

Ⅰ级：关节间隙可疑变窄，可能有骨赘。

Ⅱ级：有明显的骨赘，关节间隙轻度变窄。

Ⅲ级：中等量骨赘，关节间隙变窄较明确，软骨下骨质轻度硬化改变，范围较小。

Ⅳ级：大量骨赘形成，可波及软骨面，关节间隙明显变窄，硬化改变极为明显，关节肥大及明显畸形。

1.6 疾病分期标准

根据临床与 X 线，可分为以下三期：

早期：症状与体征表现为膝关节疼痛，多见于内侧疼痛，上下楼或站起时尤甚，无明显畸形，关节间隙及周围压痛，髌骨研磨试验（＋），关节活动尚可。X 线表现为 0～Ⅰ级。

中期：疼痛较重，可合并肿胀，内翻畸形，有屈膝畸形及活动受限，压痛，髌骨研磨试验（＋），关节不稳。X 线表现为Ⅱ～Ⅲ级。

晚期：疼痛严重，行走需支具或不能行走，内翻及屈膝畸形明显，压痛，髌骨研磨试验（＋），关节活动度明显缩小，严重不稳。X 线表现为Ⅳ级。

1.7 分级标准[3]

对症状、体征进行分级量化，按疼痛、活动与疼痛的关系、功能障碍相关的特殊检查等项进行评分，将病情程度分为轻、中、重度。

膝骨关节炎症状分级量化表

症状	轻度	中度	重度
夜间卧床休息时疼痛或不适	有不适感，稍活动后消失	时有疼痛	持续疼痛
晨练或者起床后疼痛加剧	有不适感，稍活动后消失	有不适感，稍活动后减轻	疼痛明显，活动后不能减轻
行走时疼痛或不适	长途行走 >1km 后出现	短途行走 <1km 后出现	稍行走加剧
从坐位站立时疼痛或不适	有轻度疼痛或不适	疼痛不明显，无需帮助	疼痛明显，需要帮助
最大行走距离（可以伴痛行走）	>1km，但有限	0.3～1km	<300m
日常活动	偶有困难	困难	不能
登上标准登机梯	能	困难	不能
走下标准登机梯	能	困难	不能
蹲下或者弯曲膝关节	能	困难	不能
在不平的路面行走	能	困难	不能

2 中医诊断标准及分型

2.1 诊断依据

依据中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》。

初起多见腰腿、腰脊、膝关节等隐隐作痛，屈伸、俯仰、转侧不利，轻微活动稍缓解，气候变化加重，反复缠绵不愈。

起病隐袭，发病缓慢，多见于中老年人。

局部关节可轻度肿胀，活动时关节常有弹响摩擦音。严重者可见肌肉萎缩，关节畸形，腰弯背驼。

X 线检查：骨质疏松，关节面不规则，关节间隙狭窄，软骨下骨质硬化，以及边缘唇样改变，骨赘形成。

查血沉、抗“O”、黏蛋白、类风湿因子、血尿酸、肾功能等，与风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风性关节炎、红斑狼疮相鉴别。

2.2 中医证候诊断标准

2.2.1 阳虚寒凝证

主症：肢体关节疼痛、重着。

次症：屈伸不利，天气变化加重，昼轻夜重，遇寒痛增，得热稍减。舌淡，苔白，脉沉迟缓。

2.2.2 肝肾不足、筋脉瘀滞证

主症：关节疼痛，胫软膝酸。

次症：活动不利，运动牵强，舌质偏红，苔薄或薄白，脉沉弱，尺脉尤甚。

2.2.3 脾肾两虚、湿着关节证

主症：关节疼痛，肿胀积液。

次症：活动受限，舌质偏红或舌胖质淡，苔薄或薄腻，脉滑或弦。

2.2.4 肝肾亏虚、痰瘀交阻证

主症：关节疼痛，肿胀肥厚，痿弱少力。

次症：骨节肥大，活动受限，舌质偏红或舌胖质淡，苔薄或薄腻，脉滑或弦细。

针灸治疗概况

针灸作为一种非药物治疗手段对膝骨关节炎的治疗有较好的疗效，在众多的古代文献中都有记载，现代文献中也有大量报道。

1 现代文献

1.1 辨证治疗方面

针灸治疗膝骨关节炎可缓解疼痛、晨僵，改善关节功能，减轻关节肿胀，阻止和延缓疾病的发展，保护关节功能，改善生活质量，多数病人预后良好。

针灸治疗膝骨关节炎具有安全、有效、毒副作用少等优点，临床报道也比较多，故使用广泛，患者接受度较好[6,7]。有文献报道，针灸治疗的经济性价比高，从远期效益上看，针灸治疗的成本评估远优于常规治疗[189]。

针灸治疗膝骨关节炎可以早、中、晚分期治疗。在明确分期及病因的基础上，对症治疗。总的原则为舒筋利节、活络止痛。早期，以通经活络、行气止痛、补益肾气为主，选取局部穴位，辨证论治。中期，行气活血、消肿止痛、补益脾肾，局部选穴结合辨证治疗。晚期，舒筋活络、理气止痛、补益肝肾，采用局部选穴为主，结合辨证治疗。

1.2 刺灸法方面

针灸治疗膝骨关节炎，选穴多以膝关节周围经穴和阿是穴为主，包括足三里、阳陵泉、阴陵泉、内膝眼、犊鼻、梁丘、血海等，根据不同的中医证型辨证选穴治疗。阳虚寒凝，加命门、关元；肝肾不足、筋脉瘀滞，加肾俞、承山；脾肾两虚、湿着关节，加肾俞、三阴交；肝肾亏虚、痰瘀交阻，加肾俞、太溪、地机、丰隆。操作上，针刺手法多选择泻法或平补平泻。针刺深度上，根据具体情况，可深刺也可浅刺。灸法上，多选择温针灸、直接灸或悬灸。

依据目前大量的文献报道，针灸对于膝骨关节炎的治疗主要通过舒筋利节、活络止痛以缓解疼痛，改善关节功能，属于 KOA 的常规治疗方法之一。治疗手段上多针灸并用，或是毫针刺法结合推拿、电针、TDP 照射等多种方法共同使用，也有使用火针、刺络拔罐疗法、针刀、穴位注射或针药并用等进行治疗，根据患者的主要症状，可选择几种针灸治疗措施综合使用[173,174]。

对于初诊以及早期症状不重的患者，非药物疗法是首选的治疗方法[5]，针灸作为非药物疗法之一，可以作为治疗膝骨关节炎的基础疗法。虽然在早、中、晚三期都可以进行针灸治疗，但是仍以早期干预效果更好，更有利于减轻疼痛、改善功能。

患者还应注重自我行为疗法、减肥、减少病变关节的应力和承重、加强股四头肌肌力训练，个别膝关节不稳定者可穿戴护具等，对膝骨关节炎的预防、治疗都有较好的作用。

针灸结合中药疗法在本病的治疗中也得到广泛使用。内服外用皆可，具有镇痛、消肿的作用。多用补肝肾、强筋骨、活血化瘀、祛风除湿等药物。内服方可以改善关节软骨的退行性变[8]。中药外敷可以通经脉、行气血、濡筋骨，改善肌肉萎缩，解除痉挛，消肿止痛[9]。

2 古代文献

古代文献对于针灸治疗膝骨关节炎的记载，多数体现在对于“膝痛”“不能屈伸”“无力”“不仁”等症状的治疗，以毫针刺法为主，也可用温针、火针、艾灸疗法，还可以用刺血疗法，多取委中穴。选穴以局部经穴和阿是穴为主，如阴陵泉、阳陵泉、膝关、犊鼻、膝阳关、梁丘、伏兔、曲泉、丰隆、足三里等；配以远端辨证取穴，多用肝、脾、肾经穴，如昆仑、绝骨、然谷、肾俞等。

3 名医经验

现代名医在选穴、治疗方面，多以局部阿是穴和经穴为主，发现足三里、阳陵泉、犊鼻、膝阳

关、风市等穴用得最多，与现代文献中的使用情况基本一致；同时，注重结合辨证取穴，刺法多选用毫针刺法、火针、刺络放血拔罐等。

针灸治疗和推荐方案

1 针灸治疗的原则和特点

1.1 治疗原则

针灸治疗膝骨关节炎应在明确病因的基础上，对症治疗。总的原则：舒筋利节，活络止痛；选穴以阿是穴和局部经穴为主，可结合辨证及循经远端取穴。

针刺可作为治疗膝骨关节炎的基础疗法，应用于疾病发生、发展的各期，以缓解疼痛、保护关节功能、阻止和延缓疾病的发展、改善生活质量为治疗的主要目标。

根据患者的主要症状，结合每一针灸疗法的特点，可选择几种针灸治疗措施综合使用。

1.2 选穴处方特点

针灸治疗膝骨关节炎，选穴以阿是穴及局部经穴为主，包括足三里、阳陵泉、阴陵泉、内膝眼、犊鼻、梁丘、血海等。

结合辨证及循经远端取穴：阳虚寒凝，加命门、关元等；肝肾不足、筋脉瘀滞，加肾俞、承山等；脾肾两虚、湿着关节，加肾俞、三阴交等；肝肾亏虚、痰瘀交阻，加肾俞、太溪、地机、丰隆等。

1.3 针灸方法

膝骨关节炎膝关节疼痛、晨僵、肿胀、功能受限者，建议采用毫针刺法；疼痛较剧、遇寒尤甚者，推荐采用温针疗法，或可采用艾灸治疗；膝关节畸形、肌肉萎缩、功能受限，推荐采用电针为主治疗；在毫针刺法的基础上，根据病情轻重不同，可采用穴位注射、火针、刺络放血拔罐治疗；膝关节肌肉粘连、功能受限、挛缩屈膝畸形明显者，建议采用针刀治疗。

上述针灸疗法可联合推拿、中药、理疗、功能锻炼等综合施治，根据患者的主要症状，可选择几种针灸治疗措施综合使用。

操作上，针刺手法多选择泻法；灸法多用温针灸、直接灸或悬灸。

1.4 干预时机

对于初次就诊以及早期症状不重的患者，非药物疗法是首选的治疗方法[5]，针灸可作为治疗膝骨关节炎的基础疗法。虽然在各期都可以进行针灸治疗，但是仍以早期干预效果更好，更有利于减轻疼痛、改善关节功能。

2 主要结局指标

2.1 针灸治疗的主要结局

针灸治疗膝骨关节炎，以缓解疼痛、晨僵，改善关节功能，减轻关节肿胀的结局为主。

2.2 卫生经济学评价

针灸治疗的经济性价比高。有文献报道，从远期效益上看，针灸治疗的成本评估远优于常规治疗[189]。

2.3 患者耐受及生活质量评价

针灸治疗时，注意刺激强度和穴位的交替使用，防止患者不能耐受。针灸治疗膝骨关节炎可改善症状，恢复关节功能，提高患者的生活质量。

2.4 不良反应及安全性评价

在目前检索的文献中，尚未有对针灸治疗膝骨关节炎的不良反应及安全性的相关报道。

3 注意事项

减少膝关节的负重和大幅度活动。

后期病情严重，活动严重受限时，可使用拐杖或手杖，以减轻关节的负担。

关节局部可配合热敷、推拿等疗法。

对于年龄较大的患者，应注意掌握针刺强度，防止出现晕针等情况。

膝关节进行针刺时要注意深度，火针、针刀等疗法要严格无菌操作。

病变周围伴有骨结核、骨肿瘤时禁针，关节处施灸时禁止瘢痕灸。

4 患者自我护理

4.1 积极预防

目前，膝骨关节炎一旦发生，尚未有治疗方法可改变其病程，因而在预防方面应多加注意。如减轻体重，尽量避免大的膝关节外伤，避免反复的膝关节屈曲和负重，均是降低膝骨关节炎发病的重要因素。

4.2 自我行为疗法

减少病变关节的应力和承重，建议参与自我管理项目，包括力量训练、低强度有氧运动、神经肌肉训练和参与一些体力活动，保持关节的正常关系和活动，但要避免过多行走或上下楼梯。膝关节肿痛严重时，应予休息。过度肥胖的患者应减轻体重，以减少对病变关节的压力。必要时可使用手杖或拐杖，个别膝关节不稳定者可穿戴护具。

4.3 运动疗法

适当的膝关节屈伸运动，主动加强股四头肌锻炼，改善股四头肌肌力。

4.4 预防与调摄

注意天气变化、关节保暖，避免潮湿受冷[10]。

5 推荐方案

5.1 毫针刺法

针刺在膝骨关节炎的治疗中作用明显，具有止痛、消肿、改善关节功能的作用，可以减轻疼痛症状，使关节周围肌肉松弛，缓解关节僵直，改善活动功能。毫针刺法适合膝骨关节炎疾病各期，膝关节疼痛、晨僵、肿胀、功能受限者，可使用本法。

取穴：局部选穴为主，结合辨证选穴。①主穴：阿是穴、鹤顶、犊鼻、内膝眼、阳陵泉、阴陵泉、足三里、血海、梁丘。②配穴：疼痛游走者，加风市、环跳、风门、风池；阳虚寒凝、局部疼痛明显、屈伸不利者，加命门、关元、后溪、太溪；筋脉瘀滞、膝中痛如针刺者，加膈俞、肾俞、承山；肝肾亏虚、痰瘀交阻所致的肿胀肥厚、痿弱少力者，加肾俞、太溪、地机、丰隆。

操作方法：穴位常规消毒后，取长 25～50mm 毫针进行治疗，泻法或平补平泻，留针 30 分钟，痛甚者每 10 分钟行针一次。犊鼻穴稍向髌韧带方向斜刺 0.5～1.0 寸，施以捻转泻法或平补平泻 1 分钟；鹤顶直刺 0.3～0.5 寸，施以捻转泻法或平补平泻 1 分钟；阳陵泉、阴陵泉、足三里、血海、梁丘均直刺 1.0～1.5 寸，施以提插泻法或平补平泻 1 分钟；诸穴施术后留针 30 分钟，也可配合灸法或 TDP 照射。阿是穴为阳性反应点，多出现于膝关节内侧，在股骨内侧髁附近，可以找到大小不等的条索或结节，针刺以透刺条索或结节为佳，用平补平泻手法，以得气为度。配穴可按各穴的常规刺法操作。

疗程：每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程之间间隔 3～5 天。

注意事项：①注意排除骨结核、骨肿瘤，以免延误病情。②治疗期间注意关节的保暖，避免风寒湿邪的侵袭，同时避免病变关节过度应力和承重，减少活动。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节疼痛、晨僵、肿胀、功能受限者，建议采用毫针刺法。［GDARE 1D］

解释：共搜集纳入相关文献20篇[11－30]，经综合分析，形成证据体发现，毫针刺法治疗膝骨关节炎，对症治疗结合辨证治疗，可发挥针刺镇痛的良好效用，且能改善膝关节活动度，提高生活质量。纳入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性较低，最终证据体质量等级为极低。古代文献中有大量关于该法治疗膝骨关节炎的记载。《针方六集·卷之三·尊经集·骨痹针方九十五》《针灸集成·卷二·风》《马丹阳天星十二穴并治杂病歌》《长叶君天星秘诀歌》《普济方·针灸·卷九·针灸门》《扁鹊神应针灸玉龙经·天星十一对穴·阳陵》指出该法治疗“膝痛不可屈伸”。《针灸大全·卷之一·治病十一证》《针灸甲乙经·卷十·阴受病发痹第一》《针灸集成·卷一·别穴》《针方六集·卷之六·兼罗集·疼膝头红肿二十二》《神灸经纶·卷之四·手足症治》指出该法治疗“膝痛”。名医著作《中国针灸学》（程莘农）、《新针灸学》（朱琏）、《当代针灸治疗学》（石学敏）、《杨甲三临证论治》（杨甲三）、《针灸三通法临床应用》（贺普仁）、《田从豁临床经验》（田从豁）、《针灸对穴临床经验集》（吕景山）、《针灸临床验集》（田从豁）、《针灸明理与临证》（刘冠军）、《现代针灸医案选》（刘冠军）、《金针王乐亭经验集》（王乐亭）均提及采用该法治疗“膝痛不能屈伸”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于西药（或目前常规的西医治疗方法），直接费用较低。在患者价值观和意愿方面，膝痛、屈伸不利的患者更倾向于接受该法治疗。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予强推荐。

5.2 温针疗法

温针疗法通过针柄沿针身将艾灸的热力传至病所，可温通血脉，行气活血，舒筋止痛。膝骨关节炎膝关节疼痛较重、遇寒尤甚、功能受限者，推荐采用温针疗法。

取穴：①主穴：内膝眼、犊鼻、阳陵泉、阴陵泉、足三里、梁丘、血海、阿是穴。②配穴：阳虚寒凝、疼痛较重、遇寒尤甚者，加命门、关元；筋脉瘀滞、关节功能受限者，加肾俞、承山；脾肾两虚、湿着关节、甚或肿胀者，加肾俞、三阴交。

操作方法：患者仰卧，患侧下肢半屈曲位（腘窝下用软物支持，以使下肢肌肉放松）。常规消毒穴位，取直径0.3mm、长50mm的不锈钢毫针直刺，将针刺入腧穴得气后施予适当的补泻手法，留针时，用一段长1～2cm的艾条或艾炷，插在针柄上，从下端点燃施灸，待艾条或艾炷燃尽后除去灰烬，将针取出。时间为20分钟左右，以皮肤潮红为宜。

疗程：每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程之间休息3～5天。

注意事项：膝骨关节炎膝关节红肿热痛及阴虚有热者应慎用温针疗法。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节疼痛较剧、遇寒尤甚、晨僵、肿胀、功能受限，证属阳虚寒凝、湿着关节、筋脉瘀滞者，推荐采用温针疗法。[GRADE 1C]

解释：共搜集纳入相关文献52篇[31－82]，经综合分析，形成证据体发现，温针疗法治疗膝骨关节炎，可以发挥温通血脉、缓解肌痉挛的作用，改善相关症状。纳入的文献偏倚风险低，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性较低，最终证据体质量等级为低。名医著作《中国针灸学》（程莘农）、《承淡安针灸选集》（承淡安）、《当代针灸治疗学》（石学敏）、《针灸三通法临床应用》（贺普仁）、《针灸对穴临床经验集》（吕景山）、《针灸临床验集》（田从豁）、《中医针法集锦》（刘冠军）均提及采用该法治疗“膝痛、遇寒尤甚”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于西药（或目前常规的西医治疗方法），直接费用较低。在患者价值观和意愿方面，膝痛、遇寒尤甚的患者更倾向于接受本法治疗。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予强推荐。

5.3 电针疗法

电针通过针具以接近人体生物电的微量电流刺激穴位，具有调整人体功能、加强镇痛、促进气血

循环、调整肌张力等作用。电针用于膝骨关节炎的治疗，能消炎镇痛，促进血液循环，有效地恢复股四头肌的肌力，减轻膝关节疼痛和僵硬症状，促进炎性物质吸收，利于组织代谢和修复。膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、畸形、肌肉萎缩、功能受限者，推荐采用电针为主治疗。

取穴：①主穴：犊鼻、内膝眼、阳陵泉、阴陵泉、阿是穴。②配穴：参照毫针刺法。

操作方法：患者坐位，膝关节屈曲呈90°，局部穴位消毒后，用针刺入以上穴位；采用G6805－Ⅱ电针治疗仪，每次选用2对上述穴位加电极，用疏密波或密波，刺激强度以患者局部有麻胀感或肌肉产生微小颤动而不感到疼痛为度，留针30分钟。

疗程：每日1次，10次为1个疗程，疗程之间休息3～5天。

注意事项：刺激量应缓慢逐渐增强；安装心脏起搏器者禁用电针。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、畸形、肌肉萎缩、功能受限者，推荐采用电针为主治疗。［GRADE 1C］

解释：共搜集纳入相关文献23篇[83－105]，经综合分析，形成证据体发现，电针治疗膝骨关节炎，可以起到消炎镇痛、促进血液循环的作用，有效地恢复股四头肌的肌力，减轻膝关节疼痛和僵硬症状，促进炎性物质吸收，利于组织代谢和修复。纳入的文献偏倚风险低，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性低，最终证据体质量等级为低。名医著作《针灸临床验集》（田从豁）、《中医针法集锦》（刘冠军）均提及采用该法治疗“膝痛较甚”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于西药（或目前常规的西医治疗方法），直接费用较低。在患者价值观和意愿方面，膝痛较甚、屈伸不利的患者更倾向于接受本法治疗。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予强推荐。

5.4 穴位注射疗法

穴位注射疗法治疗本病，主要选取具有活血行气、止痛的中西药物注入膝关节局部穴位、压痛点或体表阳性反应点，通过针刺及药物的双重作用，达到消除肿胀、缓解疼痛的目的。膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、功能受限者，可采用穴位注射治疗。

取穴：①主穴：足三里、阳陵泉、梁丘、血海、阴陵泉、阿是穴。②配穴：膝关节肿胀者加丰隆、三阴交、委中。

常用药物：①中药制剂：如复方当归注射液、复方威灵仙注射液、丹参注射液、红茴香注射液等。②维生素类制剂：如维生素B_1、维生素B_{12}等。③其他常用药物：如利多卡因、泼尼松、醋酸曲安奈德等。

操作方法：患者取正坐位，每次取2～4穴，选择合适的注射器和针头。局部皮肤常规消毒，刺入穴位后，回抽无血，即可将药液慢慢推入。每穴注入药液1～2mL，如果注射药物较多时，将注射针由深到浅，边退针边推药，或可更换几个方向注射药液。

疗程：每日或隔日注射1次，反应强烈者也可隔2～3日注射1次。10次为1个疗程，休息5～7天后，再进行下一个疗程的治疗。

注意事项：①严格遵守无菌操作规则，防止感染。②使用穴位注射时，向患者说明本疗法的特点和注射后的正常反应。即注射局部出现酸胀感，4～8小时内局部有轻度不适，或持续较长时间，但是一般不超过24小时。③注射部位不宜过多，以免晕针。④药液不宜注入关节腔内，以免引起关节红肿、酸痛。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、功能受限者，可采用穴位注射治疗。［GRADE 2D］

解释：共搜集纳入相关文献5篇[106－110]，经综合分析，形成证据体发现，穴位注射治疗膝骨关节炎，可以使药物直接作用于病变部位，起到消除肿胀、缓解疼痛的作用。纳入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性较低，最终证据体质量等级为极低。名医著作《田从豁临床经验》（田从豁）、《针灸临床验集》（田从豁）均提及采用该法治疗“膝痛不能屈伸”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于西药（或目前常规的西医治疗方法），直接费用低。在患者价值观和意愿方面，膝痛的患者更倾向于接受本法治疗。穴位注射疗法对于膝骨关节炎疗效确切，但对于施术者的技术水平要求较高，操作有一定的危险性。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予弱推荐。

5.5 火针疗法

火针疗法通过对针体的加热，直接迅速刺激膝关节病灶及反应点，能消除或改善局部组织水肿、充血、渗出、粘连、钙化、挛缩、缺血等变化，发挥减轻疼痛及改善关节功能活动的作用。膝骨关节炎膝关节功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显，证属阳虚寒凝、筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，建议采用火针治疗。

取穴：①主穴：内膝眼、犊鼻、鹤顶、足三里、膝周阿是穴1～2个。②配穴：脾肾两虚、湿着关节者加阴陵泉；劳伤血瘀者加血海；阳虚寒凝、寒湿阻络者加膝阳关。

操作方法：①消毒：选定穴位后进行严格消毒，先用碘酒消毒，再以75%酒精脱碘。②烧针：一手持酒精灯，另一手持针，靠近施术部位，先烧针身，后烧针尖，烧至通红发白后施术。③具体方法：烧针后对准穴位，速进速出。可刺2～5分深，刺后用无菌干棉球迅速按压针孔，以减轻疼痛。针孔的处理，视针刺深浅而定。若针刺2～3分深，可不做特殊处理；若针刺4～5分深，可用消毒纱布敷贴，胶布固定1～2天，以防感染。

疗程：隔日治疗1次，5次为1个疗程。疗程之间休息5天。

注意事项：①治疗过程中，对于有关节腔积液的患者，应注意严格无菌操作，以免关节腔内感染。②以痛为腧，选穴宜少，以局部穴位为主。③施针后，局部呈现红晕或红肿未能完全消失时，应避免洗浴，以防感染。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显，证属阳虚寒凝、筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，建议采用火针治疗。[GRADE 1D]

解释：共搜集纳入相关文献13篇[111－123]，经综合分析，形成证据体发现，火针治疗膝骨关节炎，增强刺激量，能迅速消除或改善局部病理变化。纳入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性低，最终证据体质量等级为极低。古代文献中有关于该法治疗膝骨关节炎的记载，如《席弘赋》提出治疗“膝痛屈伸不利”。名医著作《针灸三通法临床应用》（贺普仁）、《针灸治痛（第二版）》（贺普仁）均提及采用该法治疗“膝痛、屈伸不利、晨僵、屈膝畸形”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于目前常规的西医治疗方法，直接费用低。在患者价值观和意愿方面，膝痛屈伸不利、遇寒尤甚的患者更倾向于接受本法治疗。火针疗法对于膝骨关节炎疗效确切，但对于施术者的技术水平要求较高，操作有一定的危险性。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予强推荐。

5.6 刺络放血拔罐疗法

刺络放血拔罐疗法通过用三棱针、粗毫针等点刺或皮肤针叩刺相关部位出血后，再在出血部位拔罐、留罐，能显著改善膝骨关节炎肌肉紧张或痉挛程度，即刻镇痛，改善膝关节肿胀。膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、肿胀、屈膝畸形、功能受限，证属筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，可采用刺络放血拔罐治疗。

取穴：委中、足三里、阴陵泉、阳陵泉、曲泉、血海、膝阳关、内膝眼、犊鼻、鹤顶、梁丘、膝周阿是穴（多在膝关节内侧，一般取1～2个），或在穴位附近的经脉上找青紫怒张的血络处点刺。

操作方法：①刺络放血：患者卧位，每次选取2～3穴，取三棱针常规消毒后进行点刺，以微出血为度。②拔罐：视所取穴位表面积的大小，采用合适的火罐或抽气罐，在点刺后的部位上拔罐。拔火罐可用闪火法。具体方法为：用止血钳夹1个酒精（95%）棉球，用火点燃后，在罐内绕1～3圈，迅速退火后，将罐扣在应拔部位。排放血量1～20mL，每罐留置时间5～10分钟，至刺血部位血流停止。起罐后用消毒干棉球擦拭拔罐部位上的渗出物及血迹，使其自然干燥，创口较大时应贴创可贴保护伤口。

疗程：每周1～2次，治疗3～5次为1个疗程。

注意事项：①局部溃破感染化脓者慎用。②注意无菌技术操作和创面的清洁、干燥，防止搔抓而致继发性感染。③三棱针点刺穴位时，注意避开动脉血管，若误伤动脉出现血肿，以无菌干棉球按压局部止血；点刺时应以刺破血管壁为宜，尽量不要穿透血管，以免血液瘀于皮下。④治疗后12小时内刺血部位避免接触水，避免伤口感染。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节疼痛较甚、晨僵、肿胀、屈膝畸形、功能受限，证属筋脉瘀滞、痰瘀交阻者，可采用刺络放血拔罐治疗。[GRADE 2D]

解释：共搜集纳入相关文献7篇[124－130]，经综合分析，形成证据体发现，刺络放血拔罐治疗膝骨关节炎，可改善膝骨关节炎肌肉痉挛、肿胀，缓解疼痛。纳入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性低，最终证据体质量等级为极低。名医著作《中国针灸学》（程莘农）、《当代针灸治疗学》（石学敏）均提及采用该法治疗“膝痛不能屈伸”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于目前常规的西医治疗方法，直接费用较低。在患者价值观和意愿方面，膝部肿胀疼痛、屈膝畸形的患者更倾向于接受本法治疗。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予弱推荐。

5.7 灸法

艾灸可激发经气，能使凝滞、闭阻的经脉得以温通畅行，筋骨、关节得气血温煦滋养而瘀除痛减。膝骨关节炎膝关节隐痛、遇寒尤甚、功能受限，证属阳虚寒凝、肝肾不足、筋脉瘀滞、脾肾两虚、湿着关节者，可采用艾灸治疗。

取穴：局部取穴结合辨证取穴。①主穴：内膝眼、犊鼻、足三里、阳陵泉、阿是穴。②配穴：参照毫针刺法。

操作方法：有艾炷灸法、艾条灸法、温灸器灸法三种。①艾炷灸：患者坐位或仰卧位，用艾绒做成大小适宜的圆锥形艾炷施灸，可直接放在皮肤上，患者感觉皮肤发烫时移去艾炷，或者在皮肤上置姜片或附子饼后再置艾炷进行施灸，一般灸5～10壮，以局部皮肤潮红为度。②艾条灸：患者选择坐位，将艾条一端点燃，于穴位上方2～3cm处施灸，可先行回旋灸，继而行雀啄灸、温和灸，至患者局部温热而无灼痛感为宜，施灸15～20分钟，以局部皮肤潮红为度。③亦可利用一定的温灸器进行施灸。

疗程：每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程之间休息3天。

注意事项：同温针疗法。另外，老年人对温热的感觉较迟钝，要注意局部皮肤的温度，防止烫伤。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节隐痛、遇寒尤甚、晨僵、功能受限，证属阳虚寒凝、肝肾不足、筋脉瘀滞、湿着关节者，可采用艾灸治疗。[GRADE 2D]

解释：共搜集纳入相关文献42篇[131－172]，经综合分析，形成证据体发现，灸法治疗膝骨关节炎，可以起到促进血液循环、加快局部炎症渗出的吸收、促进新陈代谢的作用，减轻膝关节肿胀、疼痛和僵硬症状。纳入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经GRADE评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性低，最终证据体质量等级为极低。古代文献中有关于该法治疗膝骨关节炎的记载，如《普济方·针灸·卷九·针灸门》《针灸资生经·针灸资生经第五》。名医著作《中国灸法集粹》（田从豁）、《针灸临床验集》（田从豁）、《针灸对穴临床经验集》（吕景山）、《当代针灸治疗学》（石学敏）、《承淡安针灸选集》（承淡安）、《中国针灸学》（程莘农）均提及采用该法治疗“膝痛不能屈伸”，疗效肯定。在资源消耗方面，该法相对于西药（或目前常规的西医治疗方法），直接费用较低。在患者价值观和意愿方面，膝痛、遇寒尤甚的患者更倾向于接受本法治疗。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予弱推荐。

5.8 针刀疗法

运用针刀在骨刺形成处进针松解，配合手法解除拉应力和压应力的不平衡，使膝关节内部的力平衡得到恢复，以达到治疗目的。本法具有消肿止痛、改善晨僵和畸形、恢复关节功能的作用。膝骨关节炎膝关节肌肉粘连、功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显者，建议采用针刀治疗。

施术部位：①选择膝关节周围痛点和压痛点处作为进针点，如髌下脂肪垫、髌内外侧支持带、胫腓侧副韧带等。②结合X线，选择在膝关节边缘骨质增生处或骨刺处（此处多为应力集中点）进针。

消毒：可用碘伏在施术部位皮肤行常规消毒两遍，或以2%～3%碘酒棉球以针刀治疗点为中心向四周涂擦皮肤，每次涂擦应有1/4～1/3的区域重叠，消毒范围以进针点为中心，半径5cm以上，可根据需要扩大消毒范围。以75%酒精棉球脱碘2次。酒精挥发后，铺无菌洞巾，使进针刀点正对洞巾中间。

术前局部麻醉：患者仰卧，屈膝90°，选择好施术部位，每施术点注射0.25%～0.5%利多卡因1～2mL，严重者可配合封闭疗法。

操作方法：针刀刺入皮肤后，让刀口线和骨刺（或增生点）的竖轴垂直，在骨刺（或增生点）的尖部做切开松解术和铲磨削平术。所有骨刺的锐边磨平后，在伸直位检查一下患肢，把它和健侧相比会发现患肢有轻度内翻或外翻，或不能完全伸直。外翻则在膝关节间隙的内侧选一点，内翻则在膝关节间隙的外侧选一点，在中间部位把该处的侧副韧带切断少许。另外，在膝关节周围的痛点和压痛点处进针刀，按针刀的常规操作，先纵行后横行松解剥离。针刀术后即刻出针，用无菌干棉球或棉签按压针孔，确定不出血后可用创可贴覆盖针孔。若同一部位有多个针孔，则用无菌纱布覆盖、包扎。针刀治疗后让病人仰卧，医生一手握住患侧踝关节上方，另一手托住小腿上部，在牵拉状态下，进一步松解软组织，恢复关节力学平衡。

疗程：针刀治疗的疗程，依据患者的病变程度、身体素质、天气情况来定。每周治疗1次，最多治疗3次。

注意事项：①严格无菌操作，防止关节腔内感染。一支针刀应在一个治疗点使用，以防不同部位交叉感染。②定点必须准确，依病人的胖瘦估计进针刀的角度和深度，避免损伤骨膜。③同一治疗点在半个月内不宜重复治疗。④针刀剥离仅限于粘连的病变组织，勿将韧带附着点铲起。⑤术后注意减少膝关节活动，必要时可使用拐杖。

『推荐』

推荐建议：膝骨关节炎膝关节肌肉粘连、功能受限、疼痛、晨僵、挛缩屈膝畸形明显者，建议采用针刀治疗。[GRADE 1C]

解释：共搜集纳入相关文献14篇[175－188]，经综合分析，形成证据体发现，针刀治疗膝骨关节炎，使膝关节内部的力平衡得到恢复，具有消除肿胀、止痛、改善晨僵和畸形、恢复关节功能的作用。纳

入的文献偏倚风险高，证据体质量等级经 GRADE 评价后，因其纳入文献设计质量、一致性及精确性低，最终证据体质量等级为低。在资源消耗方面，该法相对于目前常规的西医治疗方法，直接费用低。在患者价值观和意愿方面，膝痛、功能受限、屈膝畸形的患者更倾向于接受本法治疗。针刀疗法对于膝骨关节炎疗效确切，但对于施术者的技术水平要求较高，操作有一定的危险性。结合以上情况及专家意见，对本条推荐方案给予强推荐。

参考文献

［1］张文贤．骨性关节炎——膝关节骨性关节炎的病理研究与临床诊治［M］．兰州：甘肃科学技术出版社，2008.

［2］陈百成，张静．骨关节炎［M］．北京：人民卫生出版社，2004.

［3］陈峥嵘．现代骨科学［M］．上海：复旦大学出版社，2010.

［4］中华医学会骨科分会．骨关节炎诊治指南［J］．中国临床医生杂志，2008，36（1）：28－30.

［5］中华医学会风湿病学分会．骨关节炎诊断及治疗指南［J］．中华风湿病学杂志，2010，14（6）：416－419.

［6］林琴．膝骨关节炎的针灸治疗概况［J］．福建中医药，2011，42（4）：63－64.

［7］易光强．针灸治疗膝骨关节炎的临床概况［J］．针灸临床杂志，2011，27（8）：79－80.

［8］杨锦华．膝骨关节炎用药规律及其研究思路［J］．中医研究，2010，23（5）：74－75.

［9］陈明．膝骨关节炎中医药治疗研究进展［J］．中国健康月刊，2011，30（4）：339－340.

［10］闻辉．膝骨关节炎的诊疗方案研究［J］．长春中医药大学学报，2009，25（2）：202－203.

［11］付慕勇，张智龙．辨证取穴针刺治疗膝关节骨性关节炎随机对照研究［J］．中国针灸，2011，31（12）：1062－1066.

［12］曹金明．针刺治疗膝关节骨性关节炎临床疗效分析［J］．中外医疗，2010，27：90.

［13］吕晖，倪敬年，张蓓．针刺治疗膝关节骨性关节炎的临床对照研究［J］．中日友好医院学报，2009，23（3）：169－171.

［14］郑君圣．针刺治疗膝关节骨性关节炎 90 例［J］．江西中医药，2004，（12）：58.

［15］陈燕冲．针刺治疗膝关节骨性关节炎 304 例疗效对照［J］．针灸临床杂志，2007，23（8）：19－20.

［16］王艳英．针刺治疗膝关节骨性关节炎［J］．中国民间疗法，2009，17（6）：7.

［17］丛国红，方昕．苍龟探穴法治疗膝关节骨性关节炎［J］．中国厂矿医学，2007，20（5）：547－548.

［18］胡伟民，东贵荣．苍龟探穴针法治疗膝关节骨性关节炎疼痛疗效观察［C］．中国针灸学会学术年会论文集（临床报道与体会），2009：812－815.

［19］董宝强，韩煜，李春日，等．长圆针解结法治疗膝骨关节炎的随机、单盲、多中心临床研究［J］．中华中医药杂志，2011，26（8）：1883－1885.

［20］刘辉，李晶．长圆针疗法治疗增生性膝关节炎 60 例［J］．中国中医药信息杂志，2004，11（5）：448－449.

［21］刘辉，李晶．长圆针疗法治疗增生性膝关节炎有效［N］．中国医药报，2004－06－01.

［22］田有粮，李月，李茜，等．长圆针治疗对膝关节骨性关节炎的作用［J］．中国康复，2010，25（6）：444－446.

［23］田有粮，李月，李茜，等．长圆针治疗膝关节骨性关节炎的临床研究［C］．中国针灸学会经筋诊治专业委员会 2010 学术年会暨第二届中华经筋医学论坛论文集（临床研究），2010：102－106.

［24］管宏钟，陈春海，王萃苓．长圆针治疗中老年膝骨关节炎 52 例［J］．中国针灸，2010，30（2）：140.

［25］杨薇．钩针为主治疗膝关节骨性关节炎的临床观察［J］．浙江中医杂志，2009，44（5）：359.

［26］李丰，孟羽．合谷刺治疗膝骨关节炎的临床观察［J］．甘肃中医，2009，22（5）：38.
［27］徐勇刚，宣丽华，张舒雁，等．金氏膝三针疗法治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．中华中医药学刊，2007，25（11）：2425－2426.
［28］赵莉，谢新才．芒针治疗膝关节骨性关节炎30例［J］．中医杂志，2011，52（11）：963－964.
［29］钟伟泉，老锦雄，李树成，等．内外膝眼穴不同刺法对退行性膝关节炎疗效差异的观察［J］．光明中医，2011，1：108－109.
［30］李学武，赵吉平，汤立新，等．透针法治疗膝关节骨性关节炎的临床疗效评价［J］．北京中医药大学学报，2006，29（12）：844－846.
［31］冯婕．温针配合TDP治疗膝关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2009，6：357.
［32］陈秀玲．温针灸治疗增生性膝关节炎76例临床疗效观察［J］．甘肃中医学院学报，2003，1：47－48.
［33］李淑贤．温针加刺络治疗增生性膝关节炎70例——附口服壮骨关节丸治疗30例对照［J］．浙江中医杂志，2005，5：210.
［34］郭霖，张海山．短刺加温针灸治疗退行性膝关节炎临床研究［J］．河南中医学院学报，2008，5：64－65.
［35］赵学田，卢向东，李兆文，等．温针刺法治疗膝关节骨性关节炎50例［J］．中医药通报·临床研究，2008，7（4）：49－50.
［36］洪昆达，万甜，吴淑平，等．温针对疼痛性膝骨关节炎患者镇痛效果观察30例［J］．福建中医学院学报，2010，20（3）：7－8.
［37］汤伟．温针结合透明质酸钠治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．实用医技杂志，2008，15（24）：3252－3253.
［38］李晓娟，汤宇．温针灸并超短波治疗膝关节骨性关节炎临床观察［J］．辽宁中医杂志，2011，38（6）：1185－1186.
［39］潘艳霞．温针灸和电针疗法治疗膝骨性关节炎疗效比较的队列研究［D］．北京中医药大学，2011.
［40］周薇，周仲瑜．温针灸加火罐治疗膝关节骨性关节炎33例临床观察［J］．中西医结合研究，2009，1（1）：37.
［41］朱兰，金柱，廖丽群，等．温针灸疗法治疗早期老年膝关节骨性关节炎40例临床研究［J］．中国社区医师（医学专业），2011，13（21）：190－191.
［42］陈秋明，余伯亮，宾淑芬．温针灸内外膝眼穴为主治疗膝骨关节炎［J］．针灸临床杂志，2008，24（4）：9－11.
［43］王琼芬，李曦．温针灸配合玻璃酸钠膝关节腔内注射治疗虚寒型膝骨关节炎疗效观察［J］．中国康复医学杂志，2010，25（11）：1094－1097.
［44］魏艳红，李文建．温针灸配合玻璃酸钠注射液关节腔内注射治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．光明中医，2010，25（10）：1870.
［45］董建萍，李艳艳．温针灸配合烧山火手法治疗膝关节骨性关节炎60例临床观察［J］．黑龙江中医药，2011，（3）：44－45.
［46］郭云岭．温针灸配合时间医学治疗顽固性膝骨关节炎临床观察［J］．辽宁中医杂志，2009，36（10）：1771－1772.
［47］陈武杰，林妙君，刘朝科．温针灸配合推拿治疗膝关节骨关节炎60例疗效观察［J］．辽宁中医杂志，2008，35（11）：1735－1736.

［48］朱秀平，黄少姬．温针灸配合中药熏蒸治疗膝骨关节炎68例临床疗效观察［J］．针灸临床杂志，2006，22（11）：29－31.
［49］张耀昌．温针灸配合中药治疗膝骨性关节炎的临床研究［D］．广州中医药大学，2010.
［50］姚志芳，黄晓卿，张炜．温针灸与单纯针刺对膝关节骨性关节炎疗效比较观察［J］．针灸临床杂志，2003，19（7）：32－33.
［51］王雷，韩江余．温针灸在膝关节骨性关节炎康复治疗中的临床疗效对比研究［J］．光明中医，2011，26（4）：752－753.
［52］王光宗，诸灵军．温针灸治疗老年膝关节骨性关节炎35例疗效观察［C］．中国针灸学会临床分会第十七届全国针灸临床学术研讨会论文集．2009.
［53］刘立安，马春燕，姜文．温针灸治疗老年性膝骨关节病的临床观察［J］．中国针灸，2003，23（10）：579－580.
［54］彭良．温针灸治疗老年性膝骨关节炎的临床观察［J］．辽宁中医杂志，2009，36（10）：1773－1774.
［55］李柏翰．温针灸治疗退行性膝关节炎的临床研究［D］．南京中医药大学，2010.
［56］钟国存，陈振虎．温针灸治疗膝骨关节炎30例临床观察［J］．江苏中医药，2008，40（10）：79－80.
［57］王建国，何丽娟．温针灸治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．中国针灸，2007，27（3）：191－192.
［58］吴明霞，李俐，洪昆达，等．温针灸治疗膝骨关节炎30例［J］．福建中医学院学报，2007，17（6）：37－39.
［59］丁明晖，张宏．温针灸治疗膝关节骨关节炎的临床研究［D］．广州中医药大学，2008.
［60］赖吉安．温针灸治疗膝关节骨性关节炎［J］．中国民间疗法，2009，17（1）：5－6.
［61］余健．温针灸治疗膝关节骨性关节炎32例观察［J］．实用中医药杂志，2009，25（2）：93.
［62］王光宗．温针灸治疗膝关节骨性关节炎50例疗效观察［C］．中国针灸学会临床分会第十五届全国针灸学术研讨会论文集．
［63］黄朝曦．温针灸治疗膝关节骨性关节炎52例［J］．福建中医药，2007，38（5）：23.
［64］李志宏，李冬梅．温针灸治疗膝关节骨性关节炎55例［J］．中医外治杂志，2010，19（5）：32－33.
［65］武永利，张跃全，刘荣清．温针灸治疗膝关节骨性关节炎60例疗效观察［J］．新中医，2006，38（1）：66－67.
［66］丁明晖，张宏，李燕．温针灸治疗膝关节骨性关节炎随机对照研究［J］．中国针灸，2009，29（8）：603－607.
［67］吴绵绵．温针灸治疗膝关节骨性关节炎的临床观察［J］．中外医疗，2010，（28）：30.
［68］李常度，黄信勇，杨旭光．温针灸治疗虚寒型膝骨关节炎疗效观察［J］．中国针灸，2006，26（3）：189－191.
［69］严兴科，张燕，郑魁山，等．温通针法与电针治疗膝骨性关节炎的临床对照研究［J］．中国康复医学杂志，2010，25（5）：447－450.
［70］洪昆达．温针灸治疗阳虚寒凝型膝骨关节炎的临床研究［D］．福建中医学院，2008.
［71］邱玲，翟佳丽，刘迪，等．温针内外膝眼配合康复训练治疗震后板房区膝关节骨关节炎的疗效观察［J］．现代中西医结合杂志，2011，20（4）：391－393.
［72］李绪领，初坤，于年雁，等．温针配合拔罐治疗膝关节疼痛42例［J］．针灸临床杂志，2000，16（9）：31.

［73］严成龙．温针配合玻璃酸钠治疗膝骨关节炎临床疗效观察［J］．辽宁中医药大学学报，2011，13（3）：159－160.
［74］冯月英，曹金山，李霞，等．温针配合超短波治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．针灸临床杂志，2004，20（7）：34－35.
［75］邱玲，翟佳丽，刘迪，等．温针配合康复训练治疗震后板房区膝骨关节炎疼痛的疗效观察［J］．辽宁中医杂志，2011，38（4）：722－724.
［76］王剑波，王延琳，卢永屹，等．温针透刺治疗老年膝骨关节炎疗效分析［J］．上海针灸杂志，2010，29（6）：390－392.
［77］赵学田，卢向东，李兆文，等．温针刺法治疗膝关节骨性关节炎51例［J］．中医药通报·临床研究，2008，7（4）：49－51.
［78］洪昆达，万甜，吴淑平，等．温针对疼痛性膝骨关节炎患者镇痛效果观察31例［J］．福建中医学院学报，2010，20（3）：7－9.
［79］汤伟．温针结合透明质酸钠治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．实用医技杂志，2008，15（24）：3252－3254.
［80］李晓娟，汤宇．温针灸并超短波治疗膝关节骨性关节炎临床观察［J］．辽宁中医杂志，2011，38（6）：1185－1187.
［81］潘艳霞，刘志顺．温针灸和电针疗法治疗膝骨性关节炎疗效比较的队列研究［D］．北京中医药大学，2011.
［82］周薇，周仲瑜．温针灸加火罐治疗膝关节骨性关节炎34例临床观察［J］．中西医结合研究，2009，1（1）：38.
［83］李文凤，赵慧玲．电热针量化治疗膝骨关节炎阳虚寒凝型的临床疗效研究［D］．北京中医药大学，2010.
［84］王建，钱振福，夏玉卿，等．电热针配合毫针治疗膝关节骨性关节炎99例［J］．中医杂志，2011，52（12）：1058－1059.
［85］林凌峰，梁燕萍．电热针治疗膝骨关节炎临床观察［J］．中国针灸，2005，25（10）：689－690.
［86］老锦雄，邓聪．电温针配合中药治疗膝骨关节炎临床观察［J］．上海针灸杂志，2003，22（8）：26－27.
［87］盛鹏杰，程聪，田锦鹰，等．电温针治疗膝骨关节炎100例临床报道［C］．中华中医药学会外治分会第四次学术会议会刊．
［88］盛鹏杰，胡士平，程聪，等．电温针治疗膝骨关节炎的临床观察［J］．湖北中医杂志，2008，30（10）：29－30.
［89］邵勇．电温针治疗膝关节骨性关节炎40例［J］．光明中医，2011，26（5）：1008.
［90］蒋涛，杨桂芳，赵飞，等．电针超短波配合鹿瓜多肽治疗膝关节骨性关节炎30例［J］．河南中医，2010，30（5）：470－471.
［91］傅立红．电针后隔姜灸治疗膝关节骨性关节炎50例［J］．针灸临床杂志，2007，23（4）：31－32.
［92］李艳．电针加TDP及电脑中频治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．针灸临床杂志，2010，26（3）：23－24.
［93］魏东风，周宏雷．电针加中频理疗治疗高龄老年人膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．中华保健医学杂志，2010，12（2）：141－142.
［94］佟方明．电针结合奇正消痛贴治疗膝骨关节炎的60例疗效观察［J］．中国实用医药，2011，6（12）：150－151.

［95］张佩伦，许能贵．电针结合温针灸治疗退行性膝关节炎的临床研究［D］．广州中医药大学，2007.
［96］罗雪梅，谢学光，庞贞兰．电针结合药物治疗膝关节骨性关节炎 56 例［J］．中国中医药信息杂志，2008，15（2）：68－69.
［97］陈铭洪，王荣祥，明顺培，等．电针疗法对老年退化性膝关节炎之额外功效随机受控研究［C］．第三届世界中西医结合大会论文摘要集．
［98］徐胜军，王艳，赵辉．电针配合刺络拔罐治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．实用中医药杂志，2009，25（8）：553－554.
［99］徐展琼，刘天柱．电针配合温阳通痹中药治疗坐骨神经痛的疗效观察［J］．中国中医药现代远程教育，2011，9（2）：64－65.
［100］常建军，梁涛，李瑜．电针配合药饼灸治疗膝骨关节炎 100 例［J］．中国中医药现代远程教育，2008，6（7）：688－689.
［101］贾一波．电针配合中药热敷治疗膝关节骨性关节炎 80 例［J］．光明中医，2010，25（7）：1236－1237.
［102］裘敏蕾，戴琪萍，石印玉，等．电针膝眼穴治疗膝骨关节炎的临床研究［J］．中医正骨，2006，18（3）：15－16.
［103］吴志宏，包飞．电针治疗膝骨关节炎临床对照试验［J］．中国骨伤，2008，21（3）：170－171.
［104］吴建丽，高维滨．电针治疗膝关节骨性关节炎临床观察［J］．针灸临床杂志，2010，26（8）：38－39.
［105］王瑞森，于天源．电针治疗膝关节骨性关节炎临床疗效之研究［D］．北京中医药大学，2006.
［106］林宝计．超短波加穴位注射治疗退行性膝关节炎 168 例［J］．现代康复，1999，3（12）：1448.
［107］谢一兵．温针加穴位注射治疗增生性膝关节炎 120 例［J］．福建中医药，1998，29（2）：39.
［108］毕秀英．穴位注射加针刺治疗骨性膝关节炎 64 例［J］．中国中医药科技，1998，5（6）：391.
［109］谢芝亿．穴位注射结合针灸治疗膝关节骨性关节炎临床观察［J］．贵阳中医学院学报，2005，27（2）：41－42.
［110］杨晋红．针刺加穴位注射治疗增生性膝关节炎［J］．云南中医中药杂志，1997，18（6）：31－32.
［111］卢文，刘淳．火针、刺血治疗退行性膝关节炎临床疗效观察［J］．中国中医骨伤科杂志，2009，17（10）：52－53.
［112］卢得建，杨丽艳，梅世伟．火针和温针治疗膝骨关节炎的临床对比研究［C］．广东省针灸学会第十一次学术研讨会论文汇编．
［113］卢得建，李艳慧．火针和温针治疗膝骨关节炎的临床对比研究［D］．广州中医药大学，2009.
［114］朱虹．火针结合拔罐法治疗膝关节骨性关节炎 56 例［J］．南京中医药大学学报，2010，26（6）：475－475.
［115］高广忠．火针结合放血法治疗老年性膝关节炎 60 例临床观察［J］．江苏中医药，2011，43（2）：73.
［116］马新平，李净草，李柱．火针配合灵龟八法治疗膝关节骨性关节炎 39 例［J］．中国中医急症，2011，20（2）：301－302.

［117］赵维杰．火针配合中药治疗膝骨关节炎［J］．中国民族民间医药，2010，19（9）：167.
［118］罗正中，范小利，孙发星，等．火针温灸拔罐与针刺拔罐治疗老年性膝关节病疗效对比［J］．中国针灸，1998，（3）：145－146.
［119］彭易雨，景绘涛．火针膝眼穴为主治疗膝关节骨性关节炎120例疗效观察［J］．河北中医药学报，2006，21（4）：25－26.
［120］旷秋和．火针治疗膝骨关节炎50例疗效观察［J］．针灸临床杂志，2006，22（5）：19－20.
［121］黄曙晖．火针治疗膝关节骨性关节炎患者的临床观察［C］．针灸治疗痛证国际学术研讨会论文汇编．
［122］李萍，王黎明．火针治疗退行性膝关节炎41例［J］．辽宁中医杂志，2002，10：614.
［123］李亚东．火针治疗膝关节骨性关节炎49例［J］．山西中医，2002，3：42.
［124］王曙辉．针刺结合刺络放血疗法治疗膝关节骨性关节炎的临床随机对照研究［J］．针刺研究，2010，35（2）：129－133.
［125］皮书高．针刺放血治疗膝骨性关节炎103例［J］．中国中医药现代远程教育，2013，11（14）：47－48.
［126］宋丰军．温针灸配合刺络泻血治疗老年性膝骨关节炎［J］．浙江中医杂志，2011，46（11）：832－833.
［127］郭奋进．经筋刺法加放血为主治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2013，32（8）：668－670.
［128］伏秀霞．短刺温针灸配合刺络拔罐治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2011，30（8）．
［129］董桂军．刺血疗法联合中药口服治疗膝骨关节炎58例疗效观察［J］．四川中医，2013，31（7）：124－126.
［130］丛莘，金庆文．针灸结合刺络放血治疗骨性膝关节炎的临床观察［J］．中国自然医学杂志，2004，6（3）．
［131］廖钰，张君幸，冯雪芳，等．雀啄灸法治疗膝骨关节炎的临床研究［J］．针灸临床杂志，2009，（2）．
［132］王秀梅，曹锦瑾，沈雪勇，等．艾灸治疗膝骨关节炎随机对照研究［J］．中国针灸，2011，31（12）：1057－1061.
［133］陈波，方志聪，熊芳丽．艾灸和针刺治疗对膝骨关节炎患者临床症状影响与疗法特点调查的对比研究［J］．辽宁中医杂志，2011，38（6）：1186－1188.
［134］徐明芳，肖晓华，于青．艾灸加药物注射治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2011，30（5）：318－320.
［135］苏佳灿，曹烈虎，陈维华，等．艾灸联合手法治疗膝骨关节炎临床疗效观察［J］．同济大学学报（医学版），2009，30（5）：79－82.
［136］姚俊红．艾灸配合推拿治疗膝关节骨性关节炎45例［J］．山东中医杂志，2009，28（3）：179－180.
［137］李宁，吴滨，张永玲．艾灸配合运动疗法治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．中国针灸，2002，22（11）：729－731.
［138］张前进，苏佳灿，张春才，等．艾灸与塞来昔布治疗膝骨关节炎临床效果及安全性观察［J］．中国中医骨伤科杂志，2011，19（1）：13－15.
［139］何勇，徐阳平，霍雄涛．艾灸治疗膝关节骨关节炎的临床研究［J］．中国中医骨伤科杂志，2009，17（3）：38－39.

［140］李忠桥．艾灸治疗膝关节骨性关节炎35例疗效观察［J］．河北中医，2010，32（6）：888－889.
［141］田建丹，李晓红．艾灸治疗膝关节骨性关节炎80例疗效观察［J］．长春中医药大学学报，2010，6（6）：914.
［142］苏佳灿，曹烈虎，李卓东，等．艾灸治疗膝关节骨性关节炎临床疗效的病例对照试验［J］．中国骨伤，2009，22（12）：914－916.
［143］袁训林．艾炷灸治疗膝关节退行性骨关节炎的疗效观察［J］．针灸临床杂志，2011，27（5）：41－42.
［144］王思成，曹烈虎，李卓东，等．艾灸治疗膝骨关节炎临床疗效观察［C］．第十七届全国中西医结合骨伤科学术研讨会论文汇编，2009.
［145］黄静．瘢痕灸治疗膝骨关节炎50例疗效观察［J］．针灸临床杂志，2002，18（3）：44－45.
［146］宋阳春，孙奎，杨永晖，等．隔附子饼灸配合推拿治疗膝骨关节炎临床观察［J］．中医药临床杂志，2008，20（4）：403－404.
［147］孙奎，杨永晖，杨骏，等．隔附子饼灸治疗肝肾不足型膝骨关节炎的临床观察［J］．上海针灸杂志，2008，27（4）：9－10.
［148］孙奎，杨骏，沈德凯．隔附子饼灸治疗肝肾不足型膝原发性骨关节炎［J］．中国针灸，2008，28（2）：87－90.
［149］孙奎，苏志强，杨骏．隔附子饼灸治疗肝肾不足型膝原发性骨关节炎的临床观察［C］．世界针灸学会联合会成立20周年暨世界针灸学术大会论文摘要汇编．
［150］刘俊良．隔姜灸与温针治疗膝关节骨关节炎的临床观察［D］．广州中医药大学，2010.
［151］杨永晖，孙奎，苏国宏，等．隔三七饼灸治疗气滞血瘀型膝原发性骨性关节炎临床研究［J］．中医药临床杂志，2008，20（1）：53－55.
［152］李秀彬，向诗余．隔物温和灸对治疗肝肾亏虚、痰瘀交阻型膝骨关节炎疗效的影响［D］．湖北中医学院，2007.
［153］李秀彬．隔物温和灸治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2010，29（3）：178－180.
［154］李建武，向诗余，马志毅，等．隔物温和灸治疗膝骨关节炎临床观察［J］．中国针灸，2008，28（1）：17－19.
［155］童惠云，李秀彬．隔物温和灸治疗膝骨关节炎临床研究［J］．针灸临床杂志，2006，22（12）：10－12.
［156］周忠良，孙奎，程红亮，等．隔药灸治疗血瘀型膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2010，29（1）：45－47.
［157］刘慧，朱跃兰．火灸治膝骨关节炎的临床研究［D］．北京中医药大学，2010.
［158］康明非，陈日新，付勇．热敏点灸治疗膝关节骨性关节炎的临床疗效研究［J］．江西中医学院学报，2006，18（2）：27－28.
［159］黄曙晖，冯碧君，于鹏，等．热敏灸治疗膝关节骨性关节炎35例临床观察［J］．新中医，2009，41（5）：86－88.
［160］谢丁一，迟振海，张波，等．热敏灸治疗膝关节骨性关节炎不同灸量的疗效观察［J］．江西中医药，2011，42（1）：66－68.
［161］陈明人，熊俊，陈日新，等．热敏灸治疗膝关节骨性关节炎不同灸量疗效比较的循证方案设计［J］．江西中医药，2010，41（12）：45－47.
［162］李茜，朱江．神阙灸配合电针局部穴位治疗阳虚寒凝型膝关节骨性关节炎的临床研究［D］．北京中医药大学，2006.
［163］李茜，朱江．神阙灸配合电针治疗阳虚寒凝型膝骨关节炎疗效观察［J］．中国针灸，2008，

28（8）：565－568.
［164］林家驹，陈利芳．天灸治疗膝关节骨性关节炎临床疗效观察［J］．浙江中医药大学学报，2008，32（3）：328－329.
［165］张胜，关俊辉．温和灸治疗阳虚寒凝型膝骨关节炎［D］．广州中医药大学，2009.
［166］王丽祯．艾灸疗法与膝骨关节炎［N］．上海中医药报，2010－01－29.
［167］盛刚．灯火疗法治痹症［J］．四川中医，1994，6：56.
［168］夏虹波，于金凤，王春玲．灸法治疗增生性膝关节炎的护理体会［J］．针灸临床杂志，2000，16（5）：50－51.
［169］颜娟，易海连．麦粒灸治疗膝骨关节炎80例临床观察［J］．云南中医中药杂志，2011，32（7）：56－57.
［170］陈波，熊芳丽，方志聪，等．温和灸对中老年膝骨关节炎患者生活能力与生活质量的影响［J］．山东医药，2010，50（32）：43－44.
［171］付勇，康明非，陈日新，等．无痛化脓灸治疗膝关节骨性关节炎疗效观察［J］．中国针灸，2007，27（7）：513－515.
［172］陈波，熊芳丽，方志聪，等．膝周腧穴温和灸对膝骨关节炎患者生活能力与生活质量疗效影响的研究［C］．中国针灸学会针推结合专业委员会成立大会暨针灸教育与腧穴应用学术研讨会论文汇编．
［173］周忠良．针刺配合运动疗法治疗膝关节骨性关节炎临床观察［J］．中医药临床杂志，2007，19（5）：481－482.
［174］刘强．针刺结合运动疗法治疗膝关节骨性关节炎80例［J］．广西中医药，2009，32（4）：29－30.
［175］刘福水，郭长清．针刀与关节腔注射玻璃酸钠治疗膝骨关节炎疗效比较多系统评价和Meta分析［J］．中华中医药杂志，2012，27（4），999－1002.
［176］刘福水．针刀与针灸治疗膝骨关节炎疗效比较多Meta分析．中国组织工程研究［J］，2012，16（44）：8235－8249.
［177］郭长清．针刀松解法对膝骨关节炎关节周围压痛的效果评价［J］．成都中医药大学学报，2010，33（3）：3－5.
［178］张义，郭长青，张秀芬，等．针刀松解法治疗膝骨关节炎临床对照研究［J］．中国科技信息，2007，18：219－220.
［179］雷庆良．小针刀配合中药治疗膝关节骨性关节炎肝肾不足阳虚寒凝证临床观察［J］．新中医，2010，3：45－46.
［180］陈建雄，童娟，姚红．小针刀治疗膝骨关节炎临床研究［J］．中国中医急症，2007，7：819－820.
［181］李冬．针刀“三线九点”法治疗膝骨关节炎临床研究［D］．湖北中医药大学，2011.
［182］胡水荣，尹利华，李万瑶．针刀改善膝骨关节炎症状的临床研究［J］．江西医药，2009，11：1093－1095.
［183］吕春云．针刀疗法治疗膝骨关节炎的疗效观察［J］．临床合理用药杂志，2009，6：55－56.
［184］宋阳春，孙奎，朱俊琛，等．针刀配合肌力平衡手法治疗膝骨关节炎的临床研究［J］．中医正骨，2012，9：20－23.
［185］朱国庆，韦兆玲，苏慧，等．针刀微创治疗膝骨关节炎疗效观察［J］．上海针灸杂志，2009，2：98－99.
［186］谢进，孟凯，王式鲁．自制小针刀治疗膝骨关节炎124例疗效观察［J］．山东医药，2008，

5：103 – 104.

［187］尹利华，胡水荣，王安，等．针刀治疗膝骨关节炎 40 例疗效观察［J］．中医药导报，2009，1：58 – 59.

［188］彭溶，温建民，梁朝．针刀治疗膝骨关节炎疗效评价［J］．中医药临床杂志，2011，5：414 ~ 416.

［189］Ratcliffe，J.，K. J. Thomas，H. MacPherson and J. Brazier（2006）. A randomised controlled trial of acupuncture care for persistent low back pain：cost effectiveness analysis. BMJ 333（7569）：626.

附　　录

1　本《指南》专家组成员和编写组成员

专家组成员

姓名	性别	职称	工作单位	课题中的分工
史丽萍	女	教授	天津中医药大学中医学院	临床问题的确定
高　旸	女	主任医师	天津中医药大学第一附属医院	临床问题的确定
潘兴芳	女	副教授	天津中医药大学针灸推拿学院	推荐方案专家意见审核
孟向文	女	副教授	天津中医药大学针灸推拿学院	推荐方案专家意见审核
刘爱峰	男	副主任医师	天津中医药大学第一附属医院	推荐方案专家意见审核
郭长青	男	教授	北京中医药大学针灸推拿学院	推荐方案专家意见审核
贾春生	男	教授	河北中医学院	推荐方案专家意见审核
高希言	男	教授	河南中医学院	推荐方案专家意见审核
张洪涛	男	教授	甘肃省中医院	推荐方案专家意见审核
李义凯	男	教授	南方医科大学中医学院	推荐方案专家意见审核
回克义	男	教授	内蒙古自治区中医院	推荐方案专家意见审核
杨永晖	男	主任医师	安徽中医药大学附属中西医结合医院	推荐方案专家意见审核
齐　伟	男	副主任医师	长春中医药大学第一附属医院	推荐方案专家意见审核

编写组成员

	姓名	性别	学历/职称	工作单位	课题中的分工
组长	郭　义	男	医学博士、教授	天津中医药大学针灸推拿学院	课题负责人，总体设计，组织实施
起草组	翟　伟	男	访问学者、教授	天津中医药大学针灸推拿学院	主要负责指南的撰写、组织实施
	黄　娟	女	硕士、讲师	内蒙古医科大学中医学院	主要负责英文文献检索、文献质量评价、指南的撰写
	赵　雪	女	博士、讲师	天津中医药大学针灸推拿学院	主要负责英文文献检索、文献质量评价、指南的撰写
	陈泽林	男	博士、教授	天津中医药大学针灸推拿学院	专家共识指导
	李桂兰	女	学士、教授	天津中医药大学附属保康医院	专家共识指导
	任秋兰	女	学士、教授	天津市中医药研究院附属医院	主要负责文献检索、指南的撰写
	谭亚芹	女	硕士、副教授	内蒙古医科大学中医学院	主要负责文献数据提取、文献质量评价
	田利娟	女	硕士、主治医师	新疆医科大学第一附属医院	文献收集与评价
	姜　锐	女	硕士、医师	天津河东区中医院	文献收集与评价
	郝　华	女	硕士、讲师	内蒙古医科大学中医学院	主要负责文献数据提取、文献质量评价
	奥晓静	女	硕士、讲师	内蒙古医科大学中医学院	主要负责文献数据提取、文献质量评价
	柳　青	女	硕士、医师	内蒙古赤峰市松山区中医院	主要负责文献数据提取、文献质量评价
	金　兰	女	硕士、医师	吉林省延吉市医院中医科	主要负责文献检索、数据提取
	杨　毅	女	博士、副教授	天津中医药大学语言文化学院	主要负责英文文献检索、文献质量评价
	王　红	女	硕士、教授	天津中医药大学针灸推拿学院	文献质量评价、专家共识

2 临床问题

针灸治疗膝骨关节炎的年龄段是多少？

针灸主要治疗膝骨关节炎的哪些临床症状？

针灸治疗膝骨关节炎经常运用哪些辨证方法？

膝骨关节炎发病的针灸治疗的最佳时期是什么时候？

膝骨关节炎在临床中是否需要分期治疗？如何分期？

针灸治疗膝骨关节炎常用哪些穴位？

常用的治疗膝骨关节炎发病的针灸方法有哪些？

临床治疗中是否单用针灸治疗膝骨关节炎？

针灸治疗膝骨关节炎的频次多少比较合适？

针灸治疗膝骨关节炎多长时间为一个疗程？

针灸治疗膝骨关节炎，用什么疗效评价指标较为恰当？

针灸疗法相对于其他疗法的优势有哪些？

针灸治疗膝骨关节炎的指南推荐治疗方案部分用什么体例编写易为读者接受且实用性强？

3 疗效评价指标的分级

膝骨关节炎的诊断主要依据 X 线检查并结合临床表现，疗效评价也应以这两点为主。经初步检索文献，有关膝骨关节炎的疗效评价指标以关节功能改善、疼痛为主，其中包括膝关节疼痛、肿胀、上下楼痛、晨僵、活动受限、行走步态、劳累诱发、X 线生物力学改变及步态分析比值异常等。

3.1 综合评价指标

参照《中医病证诊断疗效标准》，骨痹的疗效评定为：

治愈：关节疼痛、肿胀消失，活动功能恢复正常，实验室检查正常。

好转：关节疼痛、肿胀减轻，活动功能好转。

未愈：关节疼痛及肿胀无变化。

3.2 国内外治疗膝骨关节炎的疗效标准

该标准大多参考 WOMAC 3.0 量表，该量表将治疗 KOA 的疗效评定分为 pain（疼痛）、physical functioning（关节功能）、stiffness（发僵）三个部分，与上述所列的疗效评价指标一致。

3.3 疗效评价指标的分级

通过专家调研的形式，我们初步确定了以上疗效评价指标的分级。

3.3.1 关键性指标（7 ~9 级）

膝关节胀痛、肿胀、刺痛；髌周压痛阳性，髌骨研磨试验阳性，步态分析比值异常，X 线生物力学改变；最大行走距离或 6 分钟行走距离。

3.3.2 重要性指标（4 ~6 级）

有效率、夜间痛、间歇痛、蹲起疼痛、上下楼痛、长时间站立或行走诱发、晨僵、膝关节活动范围小、活动受限、股四头肌萎缩、关节肿大或者屈曲挛缩甚至僵直、膝关节不稳感、出现“闪失”现象。

4 检索范围、检索策略和结果

4.1 检索范围

《指南》制定的临床证据包括三个部分，即现代文献、古代文献及名医经验。

4.2 检索策略和结果

4.2.1 现代文献

现代文献部分通过检索中文数据库（CNKI、维普、CBM、万方），制定检索策略，即“痹证 or 膝骨关节炎 or 退行性膝关节炎 or 增生性膝关节炎 or 原发性膝关节炎 or 老年性膝关节炎 or 风寒湿性

膝关节炎”and“针灸疗法 or 针刺 or 针 or 灸 or 刺 or 穴 or 罐 or 波 or 贴 or 压 or 神灯 or TDP or 激光 or 红外线 or 电磁 or 放血 or 埋线 or 针刀 or 针挑 or 穴位注射 or 火针”。共检索文献 391 篇，其中随机对照 53 篇，非随机对照 104 篇，剔除综述、动物实验研究、理论探讨、个人经验、个案报道及重复文献 234 篇。

对符合纳入标准的文献分别进行数据提取，包括题目、背景、摘要、诊断标准、纳入及排除标准、干预措施、结局指标、随机化系列的产生、分配隐藏、盲法、基线资料、不良反应等方面，建立现代文献数据库。

4.2.2 古代文献

古代文献部分以电子检索《中华医典》为主，手工检索进行补充。检索整理上述文献针灸推拿类别中出现的有关“骨痹、痹症、痹证、痹、膝”等的词条。对于涉及膝骨关节炎的针灸治疗的相关内容，剔除大部分雷同和不相关的内容，最终筛选纳入文献 46 条，并进行分类整理，建立古代文献数据库。

4.2.3 名医经验

名医经验方面，课题组将民国至今比较有代表性、在临床上有一定影响的现代名老中医经验的检索给出参考范围，共 27 位专家，32 本专著。通过查阅，共有 16 本专著和 48 个条目与研究相关，经整理，48 条中有 31 条是个案总结，17 条是名医的经验总结。

5 文献质量评估结论

根据收集的证据资料，课题组对目前的临床证据进行评价，其中 RCT 和病例对照研究使用 GRADE 和 Meta 分析软件进行证据等级评价，名医经验和古代文献作为补充支持。一方面为了减少文献证据各方面的偏倚风险，课题组根据系统评价（SIGN 及 META）对偏倚风险进行说明，制订问卷，对纳入的 RCT 文章进行电话调查，确定 RCT 内部的真实性；另一方面，按照 GRADE 系统对于结局指标重要性的要求，课题组向国内 5 名针灸和骨科专家进行问卷调查，对结局指标的重要性进行了权威的确定。对于纳入的 RCT 研究，经电话联系作者确定真实性，最后结果显示，仅有 6 篇研究真实且证据级别较低，课题组根据证据等级不高的现状，决定采用会议共识和多轮专家问卷调查，对推荐意见形成专家意见推荐强度，进一步完善推荐的证据力度，形成最终的《膝骨关节炎针灸临床实践指南》。

Author（s）：

Date：2013－01－02

Question：Should 短刺加温针灸 be used for 退行性膝关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	短刺加温针灸	Control	Relative（95% CI）	Absolute		
有效率												
1	randomised trials	serious[1]	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious[1]	None	–	0%	not pooled	not pooled	⊕⊕○○ LOW	CRITICAL
Input outcome name												
0	No evidence available	–	–	–	–	None	–	–	–	–	–	–
							–	0%		–		

1 No explanation was provided.

Author（s）：

Date：2013－01－02

Question：Should 激光针刀 be used for 退行性膝关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	激光针刀	Control	Relative（95% CI）	Absolute		
有效率												
1	randomised trials	serious[1]	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious[2]	None	–	–	–	–	⊕⊕○○ LOW	CRITICAL
							–	0%		–		

1 区组随机。

2 病例数较小，有可能对结果有影响。

Author（s）：

Date：2013－01－03

Question：Should 雀啄灸 be used for 膝骨性关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	雀啄灸	Control	Relative（95% CI）	Absolute		
病情积分												
1	randomised trials	serious[1]	no serious inconsistency	serious[1]	no serious imprecision	None	－	－	－	－	⊕⊕○○ LOW	CRITICAL
							－	0%		－		

1 No explanation was provided.

Author（s）：

Date：2013－01－03

Question：Should 温针加刺络 VS 口服壮骨关节丸 be used for 增生性膝关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	温针加刺络	口服壮骨关节丸	Relative（95% CI）	Absolute		
有效率												
1	randomised trials	serious[1]	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious[1]	None	－	－	－	－	⊕⊕○○ LOW	CRITICAL
							－	0%		－		

1 No explanation was provided.

Author（s）：

Date：2013－01－03

Question：Should 温针灸 VS 口服消炎痛、通经活络丸 be used for 增生性膝关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	温针灸	口服消炎痛、通经活络丸	Relative（95% CI）	Absolute		
有效率												
1	observational studies[1]	serious[2]	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious[2]	none	–		–	–	–	CRITICAL
							–	–		–		
							–	0%		–		

1 Case－control.

2 No explanation was provided.

Author（s）：

Date：2013－01－03

Question：Should 温针配合 TDP VS 毫针 be used for 膝关节炎？

Settings：

Bibliography：

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	温针配合 TDP	毫针	Relative（95% CI）	Absolute		
有效率（follow－up 30 days）												
1	observational studies	serious[1]	serious	no serious indirectness	–	none	–	–	–	–	–	CRITICAL
							–	0%		–		

1 No explanation was provided.

短刺加温针灸 for 退行性膝关节炎

Patient or population：patients with 退行性膝关节炎
Settings：
Intervention：短刺加温针灸

Outcomes	Illustrative comparative risks* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of Participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk Control	Corresponding risk 短刺加温针灸				
有效率	See comment	See comment	Not estimable	0 (1 study)	⊕⊕⊖⊖ low[1]	
Input outcome name	Study population See comment	See comment	Not estimable	0 (0)	See comment	
	Moderate					

* The basis for theassumed risk (e. g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

1 No explanation was provided.

激光针刀 for 退行性膝关节炎

Patient or population：patients with 退行性膝关节炎
Settings：
Intervention：激光针刀

Outcomes	Illustrative comparative risks* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of Participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk Control	Corresponding risk 激光针刀				
	Study population					
有效率	See comment	See comment	Not estimable	0 (1 study)	See comment	
	Moderate					

* The basis for theassumed risk (e. g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

雀啄灸 for 膝骨性关节炎

Patient or population：patients with 膝骨性关节炎
Settings：
Intervention：雀啄灸

Outcomes	Illustrative comparative risks * （95% CI）		Relative effect （95% CI）	No of Participants （studies）	Quality of the evidence （GRADE）	Comments
	Assumed risk Control	Corresponding risk 雀啄灸				
	Study population					
病情积分	See comment	See comment	Not estimable	0 （1 study）	See comment	
	Moderate					

* The basis for theassumed risk（e. g. the median control group risk across studies）is provided in footnotes. The corresponding risk（and its 95% confidence interval）is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention（and its 95% CI）.

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

温针加刺络 compared to 口服壮骨关节丸 for 增生性膝关节炎

Patient or population：patients with 增生性膝关节炎
Settings：
Intervention：温针加刺络
Comparison：口服壮骨关节丸

Outcomes	Illustrative comparative risks* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of Participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk 口服壮骨关节丸	Corresponding risk 温针加刺络				
	Study population					
有效率	See comment	See comment	Not estimable	0 (1 study)	See comment	
	Moderate					

* The basis for theassumed risk (e. g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

温针灸 compared to 口服消炎痛、通经活络丸 for 增生性膝关节炎

Patient or population：patients with 增生性膝关节炎
Settings：
Intervention：温针灸
Comparison：口服消炎痛、通经活络丸

Outcomes	Illustrative comparative risks * (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of Participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk	Corresponding risk				
	口服消炎痛、通经活络丸	温针灸				
有效率	See comment	See comment	Not estimable	0 (1 study[1])	See comment	0 cases and 0 controls in case – control studies

* The basis for theassumed risk (e. g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

1 Case – control.

温针配合 TDP compared to 毫针 for 膝关节炎

Patient or population：patients with 膝关节炎
Settings：
Intervention：温针配合 TDP
Comparison：毫针

Outcomes	Illustrative comparative risks* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of Participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk 毫针	Corresponding risk 温针配合 TDP				
	Study population					
有效率 Follow－up：30 days	See comment	See comment	Not estimable	0 (1 study)	See comment	
	Moderate					

* The basis for theassumed risk (e. g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

CI：Confidence interval；RR：Risk ratio；

GRADE Working Group grades of evidence
High quality：Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality：Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality：Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality：We are very uncertain about the estimate.

6 本《指南》推荐方案的形成过程

本指南从初稿、修订稿到送审稿共修改十余次。

6.1 指南推荐方案初稿

由于膝骨关节炎属于慢性进行性疾病，间歇发作，其发病、分期治疗的区分界定不清，所以不适合采用分期、轻重程度、中医辨证分型等作为分类形式，最后确定以干预措施的方式作为指南推荐方案的编写形式。

以该病适用的干预措施作为指南推荐方案的框架，包括单纯针刺、温针、电针、艾灸、火针、穴位注射等。

在2013年9月28日的指南项目审查会后，根据专家提出的修改意见，将推荐方案按照膝骨关节炎的早、中、晚分期对症治疗作为推荐方案的编写形式，进行再次修改。并且经过考量，加入了针刀治疗的推荐意见。

6.2 推荐强度的形成

决定推荐强度的关键因素有四个：第一个关键因素是在充分权衡不同治疗方案利弊基础上的利弊平衡；第二个关键因素是证据质量；第三个关键因素是患者价值观和意愿的不确定或多变性；第四个关键因素是费用。

根据修改确定的专家意见征求稿：

	推荐方案	推荐意见
治疗原则	针灸治疗膝骨关节炎应以早、中、晚分期治疗。在明确分期及病因的基础上，对症治疗。总的原则是通经活络，行气活血	强推荐　（　） 弱推荐　（　） 强不推荐　（　） 弱不推荐　（　）
	早期，以通经活络、行气止痛为主，选取局部穴位配合循经取穴，辨证论治 中期，行气活血、消肿止痛，局部选穴结合辨证治疗 晚期，以疏筋活络、理气止痛、采用局部选穴为主，结合辨证治疗	
选穴处方原则	针灸治疗膝骨关节炎，选穴多以膝关节周围经穴和阿是穴为主，包括足三里、阳陵泉、阴陵泉、内膝眼、犊鼻、梁丘、血海等。早、中、晚期根据不同的中医证型辨证选穴治疗	强推荐　（　） 弱推荐　（　） 强不推荐　（　） 弱不推荐　（　）
	阳虚寒凝，加命门、关元 肝肾不足、筋脉瘀滞，加肾俞、血海、承山 脾肾两虚、湿着关节，加肾俞、三阴交 肝肾亏虚、痰瘀交阻，加肾俞、太溪、地机、丰隆	

	强推荐	弱推荐	强不推荐	弱不推荐
毫针刺				
温针				
电针				
穴位注射				
火针				
刺络拔罐				
灸法				
针刀				

注：请根据每一种推荐的治疗方法的影响强度因素及您多年的实践经验给出推荐意见，并在相应的表格中划“√”。

专家签名：

日　　期：

影响推荐强度的因素

影响因素	解释
利弊权衡	利弊之间的差距越大，越有可能被列为强推荐；利弊之间的差距越小，越有可能被列为弱推荐
证据质量	证据质量越高，越有可能被列为强推荐
价值观和意愿	价值观和意愿选择越多样化，或价值观和意愿选择不确定性越大，越有可能被列为弱推荐
成本（资源分配）	干预措施的成本越高（即消耗更多的资源），被列为强推荐的可能越小

6.2.1 毫针刺

对于膝骨关节炎早、中、晚期，膝关节疼痛、功能受限者，建议采用毫针刺法，局部取穴配合辨证取穴，以泻法强刺激为主。

证据质量：极低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。主要不良反应是晕针、皮下血肿、局部酸胀不适、皮下瘀青、滞针、疼痛等。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 20 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.2 温针灸

对于膝骨关节炎早、中期，关节疼痛较重、合并肿胀、内翻畸形、有屈膝畸形及活动受限者，推荐采用温针为主治疗。

证据质量：低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。主要不良反应与毫针刺类似，且可能出现烧烫伤。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 30 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.3 电针

膝骨关节炎早、中期，关节疼痛较重、合并肿胀、内翻畸形、有屈膝畸形及活动受限者，推荐采用电针为主治疗。

证据质量：低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。主要不良反应与毫针刺类似。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 30 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.4 灸法

膝骨关节炎早期，对于关节疼痛较重、活动受限者，可采用灸法治疗。

证据质量：极低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 10 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.5 穴位注射

膝骨关节炎中期，对于关节疼痛较重、活动受限者，可采用穴位注射疗法治疗。

证据质量：极低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。缺点是皮肉疼痛，部分患者惧针，且有可能出现药物过敏及副作用等反应。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 30 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.6 火针

膝骨关节炎晚期，关节功能受限、疼痛严重、行走需支具或不能行走、发僵、肿胀、肌肉萎缩、内翻及屈膝畸形明显者，建议采用火针疗法治疗。

证据质量：极低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。缺点是皮肉疼痛，部分患者惧针。操作需熟练，防止感染。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 30 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.2.7 刺络放血拔罐

膝骨关节炎晚期，关节功能受限、疼痛严重、行走需支具或不能行走、发僵、肿胀、肌肉萎缩、内翻及屈膝畸形明显者，可采用刺络放血拔罐的方法。

证据质量：极低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高。缺点是患者接受度稍差，有可能出现烫伤。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用约 20 元。

意愿价值观分析：此疗法需要经过与患者的沟通、讲解，进而被患者了解和接受。

6.2.8 针刀

对于常规针灸疗法疗效欠佳的膝骨关节炎患者，建议用针刀治疗。

证据质量：低质量证据。

疗效评价：对于改善膝关节功能状况、提高患者生活质量方面有着重要的临床价值。

利弊分析：安全、疗效好、无毒副作用、经济性价比高，患者易于接受。缺点是对比常规针灸疗法，创伤稍大。

资源利用及成本分析：治疗所需材料简单、易得、经济，一次治疗费用 50～100 元。

意愿价值观分析：此疗法易于被患者了解和接受。

6.3 指南推荐方案的修订和完善过程

综合考量各证据之间的权重，结合专家意见，最后形成针灸治疗膝骨关节炎的临床治疗推荐方案。目前认为 GRADE 系统是形成循证针灸临床实践指南推荐意见的较为科学的方法，但由于当前针灸治疗膝骨关节炎的临床研究证据质量很低，因此应以 GRADE 评估结果为基础，以古代医籍和名医经验为参考，以专家共识为依据，综合考量后形成膝骨关节炎循证针灸临床实践指南的推荐意见。本研究目前仅在专家讨论和少数患者意愿性的基础上进行了患者意向分析，目前还没有对专家共识以及患者价值观、意愿进行大规模调研。

7 本《指南》推荐方案征求意见稿

经过多次修改，在确定指南的最终方案后，形成指南的征求意见稿，以征求意见表的形式，在相关专家中进行问卷调查。

7.1 针灸治疗原则和特点

针灸治疗膝骨关节炎的原则是通调局部经气，消肿止痛。

针灸治疗膝骨关节炎以局部取穴为主，辅以对症治疗。

针灸治疗膝骨关节炎，选穴以阿是穴、足三里、阳陵泉、阴陵泉、内膝眼、梁丘、犊鼻、血海为主。

7.2 针刺方案

膝骨关节炎推荐以单纯针刺治疗，局部选穴为主，结合辨证选穴。

膝骨关节炎推荐以温针疗法治疗，局部选穴以内膝眼、犊鼻、阴陵泉、阳陵泉、足三里、梁丘为主。

膝骨关节炎可以灸法为主治疗，局部选穴以内膝眼、犊鼻、阴陵泉、阳陵泉、足三里、梁丘为主。

膝骨关节炎推荐以电针治疗，局部选穴以犊鼻、内膝眼、阳陵泉、阴陵泉、阿是穴为主。

可使用穴位注射、火针疗法、刺络放血拔罐、针刀疗法治疗膝骨关节炎。

8 专家意见征集过程、结果汇总及处理

我们在天津、内蒙古等地区小范围内，组织了相关专家，包括骨科、针灸、中医内科等方面的专家进行专家意见征询，采用问卷调查的形式，对已经形成的推荐方案给予“强推荐”“弱推荐”“强不推荐”“弱不推荐”的不同参考推荐形式。结果显示，对于电针和温针疗法的推荐强度较高，其他疗法，比如穴位注射、灸法等，因为使用较少，缺乏了解，弃权的选择比较多。这充分说明某种疗法的使用和地域、医生的临床使用经验等密切相关，所以有必要在总课题组的组织下，进一步在全国更大范围内进行专家意见的征询。

专家意见汇总表

	强推荐	弱推荐	强不推荐	弱不推荐
体针	22%	11%		
温针	22%	66.7%		
电针	11%	55.6%		
穴位注射	0%	22%		
火针	11%	33%		
艾灸	22%	22%		

9 会议纪要

9.1 2013 年针灸临床实践指南项目审查会会议纪要

时间：2013 年 9 月 28 日。

地点：成都。

主办单位：中国针灸学会标准化工作委员会。

承办单位：中国中医科学院针灸研究所。

参会人员：国家中医药管理局、中国针灸学会的有关领导，以及针灸行业科、教、研各方面的专家共 26 人出席了会议，同时，指南起草单位的 20 余名代表与学会秘书处工作人员也参加了会议。中国针灸学会标准化工作委员会副主任委员刘炜宏为专家组组长。

会议主持人：中国针灸学会会长、中国针灸学会标准化工作委员会主任委员刘保延。

会议议题：审查 15 项针灸临床实践指南；对 15 项针灸临床实践指南形成决议。

会议内容：

国家中医药管理局政策法规与监督司查德忠司长到会并做了重要讲话。查司长在讲话中指出，标准化工作是国家中医药管理局法监司的工作重点，受到各方面的重视，局里已陆续出台一系列关于标准化工作的规范性文件并据此指导了相关工作，中央财政为此设立了专款用于支持开展中医标准化工作。查司长鼓励针灸行业继续积极开展标准化工作，争取获得较大进展。他特别强调，要重视针灸标准体系和针灸标准化支撑体系的构建，将针灸标准的制定与应用及其评价相结合，积极推进针灸标准化培训工作。最后，查司长提出了四点建议：一要继续完善针灸标准化体系框架；二要加强标准通则的制定；三要围绕针灸临床实践来制定标准；四要夯实针灸标准制定的基础。

中国针灸学会会长、学会标委主任委员刘保延首席研究员代表学会与学会标委介绍了参加本次审查会的 15 项针灸临床实践指南项目的实施情况。在中国针灸学会标准化工作委员会的组织下，该 15 项指南的编制工作严格遵循标准化相关法规与中国针灸学会的有关规定展开。目前，各个项目组对各自编制的指南草案已在全国范围内广泛征求意见。在今年 6 月份召开的两针标委 2013 年会上，该 15 项指南草案已通过初审。本次会议受国家中医药管理局委托，由中国针灸学会标准化工作委员会组织专家对该 15 项指南送审稿进行审查。刘保延会长特别强调，临床实践指南是未来针灸标准化工作的重点，其性质更加贴近临床，其研制目的是为临床疗效和质量提供保障，所以，本次审查会的评审重点是评审各针灸临床实践指南推荐方案的实用性。刘保延会长期望本次审查会专家严格把关，以确保指南的质量，并希望没有通过审查的项目起草单位能够做好修改和完善工作。

会议对 15 项针灸临床实践指南进行了审议，根据专家评审意见及专家投票情况，会议当即得出评审结果：通过的指南有 6 项，建议修改后函审的指南有 3 项，未通过的指南有 6 项。具体情况如下：

（1）审议通过的指南项目

会议审查通过了由中国中医科学院广安门医院起草的《慢性便秘针灸临床实践指南》《腰痛针灸临床实践指南》、由北京中医药大学东直门医院起草的《原发性痛经针灸临床实践指南》、由成都中医药大学起草的《坐骨神经痛针灸临床实践指南》、由中国中医科学院针灸研究所起草的《失眠针灸临床实践指南》《支气管哮喘（成人）针灸临床实践指南》。

（2）修改后函审的指南项目

会议建议由中国中医科学院针灸研究所起草的《肩周炎针灸临床实践指南》、由天津中医药大学起草的《膝骨性关节炎针灸临床实践指南》以及由北京中医药大学东直门医院起草的《过敏性鼻炎针灸临床实践指南》3 项指南，按照评审意见修订后再行函审。

（3）未通过的指南项目

会议决定，由安徽中医药大学附属针灸医院起草的《神经根型颈椎病针灸临床实践指南》、由天津中医药大学起草的《慢性萎缩性胃炎针灸临床实践指南》、由南京中医药大学起草的《突发性耳聋针灸临床实践指南》《单纯性肥胖病针灸临床实践指南》、由浙江中医药大学附属第三医院起草的《原发性三叉神经痛针灸临床实践指南》以及由陕西中医药大学起草的《糖尿病周围神经病变针灸临床实践指南》6 项指南项目不能通过审查。会议决议未通过审查的指南项目组按照评审意见继续修改完善后，由学会标委秘书处另行安排验收审查。

最后，会议提出，对于审议通过的指南，还需要对其内容及形式进行一致性修改，各指南起草单位应按照会议审查意见进行修改后，形成报批稿，上报学会标委秘书处，经秘书处登记、审核后，上报学会批准，发布。

《膝骨关节炎针灸临床实践指南》（送审稿）专家审查意见

2013 年 9 月 28 日，全国针灸标准化技术委员会、中国针灸学会标准化工作委员会在成都组织召开了“2013 年针灸标准及临床实践指南项目审查会”，会上审查了学会标准《膝骨关节炎针灸临床实践指南》（送审稿）。以刘炜宏为组长的 21 人专家组经过认真评议形成如下意见：

本《指南》针对膝骨关节炎针灸临床实践，通过收集、整理膝骨关节炎针灸临床实践和科研的相关文献资料，调研分析，专家论证，以古今文献、临床实践为依据，详细规定了该指南简介、疾病概述、临床特点、诊断标准、治疗概况、针灸治疗、推荐方案、附件等方面，形成了《膝骨关节炎针灸临床实践指南》，并广泛征求专家意见，合理处理并分析相关意见，达成了共识。

专家组一致认为，本针灸临床实践指南编写方法符合标准化的有关规定，资料完整，用语确切，格式规范；指南框架及内容系统实用，具有科学性和可行性；膝骨关节炎针灸临床治疗推荐方案合理，具备公认性和适用性；规定的针灸临床实践指南要求符合当前的科技水平和发展方向。

专家提出如下修订建议：

1. 关于推荐方案

（1）根据不同的发病原因（原发、继发、痛风）、不同症状（疼痛、肿胀、畸形、肌肉萎缩、膝软等），考虑不同的针灸方案。

（2）推荐方案以针灸方法分类不妥。

（3）推荐方案中简介不宜用定义性语言表述；方案与临床实际不完全吻合，如温针、火针应更实用。

2. 关于针灸治疗

（1）建议加入刺络拔罐。

（2）参照《针灸临床实践指南制定及评估规范》，注意该病的分期，不可针灸是多数，只能缓解疼痛，不能治疗。

（3）各疗法适用的分期不同，能否进一步明确？

3. 其他

（1）指南目标描述不明确。

（2）古代文献和名医经验的内容宜放在附件里。

（3）格式体例应与总课题的要求一致。

（4）推荐意见不规范；各指南应有统一的推荐格式。

（5）对于各种疗法的叙述中，尤其是专业性较强的条目，注意语言的准确性，比如火针条目中操作方法、注意事项等的叙述欠妥。

根据专家评审意见及专家投票情况，建议课题组根据评审意见修改指南文本，再行报送函审。

中国针灸学会标准化工作委员会

2013 年 9 月 28 日

附：《膝骨关节炎针灸临床实践指南》项目审查专家名单

序号	姓名	职称/职务	工作单位
1	刘保延	副院长	中国中医科学院
2	刘炜宏	编审	中国中医科学院针灸研究所
3	文碧玲	教授	中国针灸学会
4	武晓冬	副研究员	中国中医科学院针灸研究所

续　表

序号	姓名	职称/职务	工作单位
5	余曙光	副校长/研究员	成都中医药大学
6	杨　骏	院长/教授	安徽中医药大学
7	赵京生	研究员	中国中医科学院针灸研究所
8	杨华元	教授	上海中医药大学
9	房繄恭	研究员	中国中医科学院针灸研究所
10	赵　宏	主任医师	中国中医科学院广安门医院
11	石　现	主任医师	解放军总医院针灸科
12	王富春	院长/教授	长春中医药大学针灸推拿学院
13	王麟鹏	主任医师	首都医科大学附属北京中医医院
14	贾春生	主任医师	河北中医学院
15	余晓阳	主任医师	重庆市中医院
16	高希言	教授	河南中医学院
17	常小荣	教授	湖南中医药大学
18	张洪涛	主任医师	甘肃省中医院
19	吕明庄	主任医师	贵州省贵阳医学院附属医院
20	王玲玲	院长/教授	南京中医药大学
21	宣丽华	主任医师	浙江中医药大学附属第一医院

9.2　中国针灸学会标准化工作委员会 2014 年针灸临床实践指南审定会会议纪要

时间：2014 年 12 月 27 日。

地点：合肥。

主办单位：中国针灸学会标准化工作委员会。

承办单位：中国中医科学院针灸研究所。

参会人员：国家中医药管理局、中国针灸学会的有关领导，以及针灸行业科、教、研各方面的专家共 29 人出席了会议，同时，9 项针灸临床实践指南起草单位的代表与学会秘书处工作人员也参加了会议。

会议主持人：中国针灸学会标准化工作委员会副主任委员刘炜宏。

会议议题：9 项针灸临床实践指南项目组作接受审查汇报；审定 9 项针灸临床实践指南。

会议内容：

中国针灸学会会长、中国针灸学会标准化工作委员会主任委员刘保延首席研究员代表学会与学会标委首先对多年来一直关心与支持针灸标准化工作的国家中医药管理局各部门特别是政策法规与监督司以及业内各方面的专家表示感谢；接着他介绍了参加本次审定会的 9 项针灸临床实践指南项目的编制概况。他指出，针灸临床实践指南是根据针灸临床优势，参照古代文献、名医经验以及现代最佳临床研究证据，结合患者价值观和意愿，系统总结出的能帮助临床医生和患者做出恰当针灸处理的指导性意见。他结合针灸发展实际并强调指出，目前世界上 180 多个国家与地区都在应用针灸，这是针灸的春天，是针灸发展适逢的难得的大好发展机遇期，遇到这样的好时机，我们应有所作为，等听完桑司长的指示和要求后，我们要做系统的总结、思考与规划，争取又好又快地多出成绩。

国家中医药管理局政策法规与监督司桑滨生司长到会并做了重要讲话。桑滨生司长在讲话中首先

肯定并赞扬了针灸标准化工作取得的成绩，他指出，在中医药标准化工作中，针灸标准化一直发挥着先导作用，在中医药国际标准化工作中，针灸针的研制工作起到引领作用并率先完成研制与发布；在中医药国家标准化工作方面，33 项现行中医药国家标准中，针灸国家标准占 29 项。桑司长接着分析了国家重视中医药标准化工作，提到自 2010 年起，国家用于中医药标准化工作的财政经费每年都在增加。他特别提到了国家标准化体制改革，改革的方向之一就是要发挥行业组织作用，保留行业标准，增加行业组织标准，以此来鼓励针灸行业要继续发挥模范带头作用。最后，桑司长提出了几点希望：一是希望针灸标准化工作在质量、水平方面继续发挥先导作用；二是希望在中医药标准化方法和程序上，针灸标准化工作也要起到引领作用；三是希望针灸行业把针灸标准化工作的好的、成功的经验总结出来，推广开去。

会议在听完总课题组与 9 项针灸临床实践指南项目组所作的接受审定汇报后，对 9 项针灸临床实践指南进行了审定，会议经过讨论形成以下意见：

（1）不确切的内容不宜列入指南，如突发性耳聋中的疏波、密波；“突发性耳聋”应按脏腑辨证取穴，古典文献不要扔，不能以创新为由而舍古典精粹；突发性耳聋 12 页方案一、方案二中的疗程不统一。

（2）对针刀等跨学科问题应作出界定，对针灸疗法的范畴应作出界定，应明确毫针、艾灸等传统方法的适用范围，是否应纳入其他特种针法，应作出限定。

（3）各指南项目组应注意：证据等级低，不等于疗效低，推荐强度是对公认度而言，不是针对疗效。

（4）要重视文献质量评价，古代文献要考虑，在解释中要增加古代文献分析，加强证据的质量。

（5）推荐方案应是综合统筹提取概括而得，而不应是诸多疗法的罗列；分型中应有中医辨证分型、归经；中医病名不应淡化。

（6）《指南》在体例、序号、术语、语言表达、结构、内容等方面应统一；名词术语、仪器设备名称应规范，如神灯，是商品名，有 TDP、特定波治疗仪、红外灸疗仪等多种称谓，建议统一使用红外灸疗仪；电针、电针疗法、电针仪三者常混用，应予规范；有些术语说明、解释不充分；运动疗法和运动针法的适用要明确。

（7）指南起草组应参照局医政司制定的中医诊疗方案、临床路径；建议病名采用中西医并用（双轨制），如无对应，可用相当于西医（中医）的病名，有利于向国际推广；疾病分期要规范，有临床分期、中医证候分期和病理分期三种分期，应重视和采用病理分期；辨证要标准，临床证据应准确，不应随意；配穴原则应予明确；针法、灸法均应明确实用；指南推荐方案应予验证，应有临床依据；名词术语要规范；评价要做到易推广性、真实客观性、代表性、共识性、有效性、安全性、指导性、实用性、可行性；推荐的方法应注重实用性、应用性，如电针的波幅、频率、阴阳极的设置等；在国际化方面，中西医辨证分型有矛盾之处，不利于国际推广；还要注意普遍性和特殊性，以及使用时机问题。

（8）推荐建议的主体要明确；推荐意见要结合教材；指南前后思路、理法方药术、辨证分型等要清晰，应前后贯穿；要考虑教材的协调性问题；应体现针灸临床辨证的思路，体现针灸的规律性。

（9）指南制定的关键是实用；证据级别上的筛选要有注释说明。

（10）肩周炎的护理中，关于针刺后洗澡的问题应统一。

（11）起草人应自审，自己要负责；建议建立专审机制，把专审与统审结合。

（12）顶层设计与原则性方面的工作需加强，针对性、精准性不够。

根据上述审定意见及专家投票情况，会议当即给出审定决议：通过对 9 项针灸临床实践指南送审稿的审定工作，各指南项目组应按照会议审定意见进行修改后，形成报批稿，上报学会标委秘书处。

《膝骨关节炎针灸临床实践指南》（送审稿）审定意见

2014 年 12 月 27 日，中国针灸学会标准化工作委员会在合肥组织召开了“中国针灸学会标准化工作委员会 2014 年针灸临床实践指南审定会”，会上审查了《膝骨关节炎针灸临床实践指南》。以中国针灸学会标准化工作委员会副主任委员刘炜宏为组长的 27 位专家组成的审查组经过认真评议形成如下意见：

本《指南》针对膝骨关节炎针灸临床实践，通过收集整理膝骨关节炎针灸临床实践和科研的相关文献资料、调研分析、专家论证，以古今文献、临床实践为依据，形成了《膝骨关节炎针灸临床实践指南》，并广泛征求专家意见。

专家组一致认为，本针灸临床实践指南的编写工作符合标准化法规与《中医药标准制定管理办法（试行）》的有关规定，资料完整，用语确切、规范。针对本针灸临床实践指南中存在的问题，与会专家提出如下修改建议：

（1）证据等级太多。

（2）个别体例不统一。

（3）“发病率”应为“流行病学”。

根据上述专家评审意见及专家投票情况，同意该指南送审稿通过审查，建议本指南项目组根据专家意见修改后，以行业组织标准级别上报审批。

中国针灸学会标准化工作委员会

2014 年 12 月 27 日

附：《膝骨关节炎针灸临床实践指南》项目审定专家名单

序号	姓名	工作单位
1	刘保延	中国中医科学院
2	黄龙祥	中国中医科学院针灸研究所
3	刘炜宏	中国中医科学院针灸研究所
4	文碧玲	中国针灸学会
5	东贵荣	上海中医药大学附属岳阳医院
6	武晓冬	中国中医科学院针灸研究所
7	王　华	湖北中医药大学
8	余曙光	成都中医药大学
9	杨　骏	安徽中医药大学第一附属医院
10	赵京生	中国中医科学院针灸研究所
11	杨华元	上海中医药大学
12	刘清国	成都中医药大学
13	储浩然	安徽中医药大学附属针灸医院
14	赵吉平	北京中医药大学东直门医院
15	赵　宏	中国中医科学院针灸研究所
16	刘智斌	陕西中医药大学附属医院
17	石　现	解放军总医院针灸科

续表

序号	姓名	工作单位
18	王富春	长春中医药大学针灸推拿学院
19	曹　炀	苏州医疗用品厂有限公司
20	高树中	山东中医药大学
21	贾春生	河北中医学院
22	杨永清	上海中医药大学
23	高希言	河南中医学院
24	余晓阳	重庆市中医院
25	张洪涛	甘肃省中医院
26	宣丽华	浙江中医药大学附属第一医院
27	朱　江	北京中医药大学针灸推拿学院